PEDOMAN
PELAYANAN DAN ASUHAN GIZI
RSD KALABAHI
2026



DAFTAR ISI

Judul
Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
BAB I. Pendahuluan 1
A. Latar Belakang 1
B. Tujuan Umum dan Khusus 2
C. Pengertian 2
BAB II. Ruang Lingkup 4
A. Ruang Lingkup Pelayanan Gizi 4
BAB III. Denah dan Standar Fasilitas 12
A. Denah Ruang 12
B. Standar Fasilitas 13
BAB IV. Tata Laksana Pelayanan 15
A. Tata Laksana Produksi dan Distribusi Makanan 15
B. Tata Laksana Pelayanan Gizi Rawat Inap .. 20
C. Tata Laksana Penyuluh dan Konsultasi Gizi21
BAB V. Tata Laksana Pelayanan Gizi Treintegras 23
A. Proses Terapi Gizi 23
B. Diagnosa Gizi 23
C. Intervensi Gizi 25
D. Monitoring dan Evaluasi 26
E. Konseling 26
BAB VI. Standar Menu 27
A. Pola Menu di Rumah Sakit Daerah Kalabahi27
B. Standar Porsi Bahan Makanan 27
C. Spesifikasi Bahan Makanan 29
D.Standar Pemberian Makanan di Rumah Sakit30
BAB VII.Logistik 39
A. Pengertian 39
B. Tujuan 39
C. Syarat Manajemen Logistik 39
D. Kegiatan Logistik Unit Gizi 39

E. Pengolahan Bahan Makanan 46
F. Pemilihan Bahan Makanan..... 46
G. Persiapan Makanan 46
BAB VII. Keselamatan Pasien..... 47
A. Pengertian..... 47
B. Tujuan 47
C. Tata Laksana Keselamatan Pasien..... 47
BAB VIII. Keselamatan Kerja 50
BAB IX .HIGIENE DAN SANITASI MAKANAN..... 55
A.P engertian Umum Dan Sanitasi 55
B.HIGENE TENAGA PENJAMAH MAKANAN 56
C.Higiene Peralatan dan pengolahan Makanan..... 57
BAB X. Pengendalian Mutu 58
A. Bentuk-bentuk Pengawasan dan Pengendalian 58
B. Ciri Sistem Pengendalian Efektif..... 61
C. Indikator Keberhasilan Upaya Gizi Rumah Sakit.....62
D. Indikator Mutu Gizi 62
BAB XI. Penutup 64
Daftar Pustaka..... 65
Lampiran

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah di berikan kepada penyusun, sehingga panduan Pelayan Gizi Rumah Sakit Daerah Kalabahi dapat selesai disusun. Dengan adanya panduan ini, diharapkan pelayanan gizi di Rumah Sakit Daerah Kalabahi dapat terlaksana sesuai Standar Prosedur Operasional (SPO) yang dibuat berdasarkan panduan yang ada.

Semoga panduan pelayanan gizi Rumah Sakit Daerah Kalabahi dapat bermanfaat bagi Rumah Sakit dan pihak-pihak terkait lainnya. Panduan pelayanan gizi ini akan di evaluasi dalam 2 tahun sekali. Saran dan kritik dari perbaikan panduan ini sangat kami harapkan.

Tim Penyusun

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Memasuki era globalisasi yang ditandai dengan persaingan dalam berbagai aspek,diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi agar mampu bersaing dengan negara lain. Kesehatan dan gizi merupakan faktor penting karena secara langsung berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia (SDM) di suatu negara, yang digambarkan melalui pertumbuhan ekonomi, usia harapan hidup, dan tingkat pendidikan. Tenaga SDM yang berkualitas tinggi hanya dapat dicapai oleh tingkat kesehatan dan status gizi yang baik. Sehingga diperlukan upaya perbaikan gizi di dalam keluarga dan pelayanan gizipada individu yang kondisi kesehatannya harus dirawat di suatu sarana pelayanan kesehatan misalnya rumah sakit.

Masalah gizi di rumah sakit dinilai sesuai kondisi perorangan yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi proses penyembuhan. Kecenderungan peningkatan kasus penyakit yang terkait gizi (*nutrition-related disease*) pada semua kelompok rentan mulai dari ibu hamil, bayi, anak, remaja, hingga lanjut usia, memerlukan penatalaksanaan gizi secara khusus. Oleh karena itu, dibutuhkan pelayanan gizi yang bermutu untuk mencapai dan mempertahankan status gizi optimal dan mempercepat penyembuhan.

Risiko kurang gizi dapat timbul pada keadaan sakit, terutama pada pasien dengan anoreksia, kondisi mulut dan gigi geligi yang buruk, gangguan menelan, penyakit saluran cerna disertai mual, muntah dan diare, infeksi berat, lansia dengan penurunan kesadaran dalam waktu lama, dan yang menjalani kemoterapi. Asupan energi yang tidak adekuat, lama hari rawat, penyakit non infeksi, dan diet khusus merupakan faktor yang mempengaruhi terjadinya malnutrisi di rumah sakit.

Hospital malnutrition merupakan masalah yang kompleks dan dinamik. Malnutrisi pada pasien di rumah sakit, khususnya pasien rawat inap berdampak buruk terhadap proses penyembuhan penyakit dan penyembuhan pasca bedah. Selain itu, pasien yang mengalami penurunan status gizi akan mempunyai resiko kekambuhan yang signifikan dalama waktu singkat. Semua keadaan ini dapat meningkatkan morbiditas dan mortalitas serta menurunkan kualitas hidup. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan pelayanan gizi yang efektif dan efisien melalui proses asuhan gizi yang terstandar.

Pelaksanaan pelayanan gizi di rumah sakit memerlukan sebuah pedoman sebagai acuan untuk pelayanan bermutu yang dapat mempercepat proses penyembuhan pasien, memperpendek lama hari rawat, dan menghemat biaya perawatan. Diharapkan buku pedoman ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi rumah sakit untuk melaksanakan kegiatan pelayanan gizi di Rumah Sakit Daerah Kalabahi.

B. TUJUAN UMUM DAN KHUSUS

Tujuan Umum

Terciptanya sistem pelayanan gizi di Rumah Sakit dengan memperhatikan berbagai aspek gizi dan penyakit, serta merupakan bagian dari pelayanan kesehatan secara menyeluruh untuk meningkatkan dan mengembangkan mutu pelayanan gizi di Rumah Sakit sesuai dengan Standar Operasional Pelayanan (SOP) yang berlaku di RSD Kalabahi.

Tujuan Khusus :

1. Memastikan makanan dan nutrisi yang sesuai dengan kebutuhan pasien berdasarkan usia, budaya, kondisi dan diagnosis pasien.
2. Memastikan bahwa pemesanan makanan dan nutrisi untuk pasien dilakukan oleh DPJP atau PPA yang berkompeten, salah satunya adalah Ahli Gizi.
3. Memastikan bahwa pasien berhak menentukan makanan sesuai dengan nilai yang dianut dengan menawarkan pilihan makanan yang memiliki nilai gizi yang sama.
4. Memberikan edukasi kepada keluarga pasien mengenai kebersihan, tata cara penyimpanan, dan kontraindikasi dari makanan yang dibawa dari luar rumah sakit dengan kondisi pasien.
5. Menjelaskan kepada keluarga pasien mengenai interaksi antara obat dan makanan yang dikonsumsi oleh pasien.

C. PENGERTIAN

Pelayanan Gizi adalah suatu upaya memperbaiki, meningkatkan gizi, makanan, dietetik masyarakat, kelompok, individu atau klien yang merupakan suatu rangkaian kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, simpulan, anjuran, implementasi dan evaluasi gizi, makanan dan dietetik dalam rangka mencapai status kesehatan optimal dalam kondisi sehat atau sakit.Terapi Giziadalah pelayanan gizi yang diberikan kepada klien berdasarkan pengkajian gizi, yang meliputi terapi diit, konseling gizi dan atau pemberian makanan khusus dalam rangka penyembuhan penyakit

pasien.Konseling gizi adalah serangkaian kegiatan sebagai proses komunikasi dua arah yang dilaksanakan oleh ahli gizi/dietisien untuk menanamkan dan meningkatkan pengertian, sikap, dan perilaku pasien dalam mengenali dan mengatasi masalah gizi sehingga pasien dapat memutuskan apa yang akan dilakukannya.

Pelayanan gizi di rumah sakit diberikan dan disesuaikan dengan keadaan pasien berdasarkan keadaan klinis, status gizi, dan status metabolisme tubuh. Keadaan gizi pasien sangat berpengaruh pada proses penyembuhan penyakit, sebaliknya kondisi penyakit juga dapat berpengaruh terhadap keadaan gizi pasien. Sehingga diperlukan asuhan gizi yang tepat sesuai kondisi pasien untuk mempercepat proses penyembuhan penyakit. Asuhan Giziadalah serangkaian kegiatan yang terorganisir/terstruktur yang memungkinkan untuk identifikasi kebutuhan gizi dan penyediaan asuhan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Masalah gizi di rumah sakit dinilai sesuai kondisi perorangan yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi proses penyembuhan. Kecenderungan peningkatan kasus penyakit yang terkait gizi (nutrition related diseases), memerlukan penatalaksanaan gizi secara khusus. Oleh karena itu, dibutuhkan pelayanan gizi yang bermutu untuk mencapai dan mempertahankan status gizi yang optimal dan mempercepat penyembuhan.

Penyuluhan gizi adalah serangkaian kegiatan penyampaian pesan-pesan gizi dan kesehatan yang direncanakan dan dilaksanakan untuk menanamkan dan meningkatkan pengertian, sikap serta perilaku positif pasien/klien dan lingkungannya terhadap upaya peningkatan statusgizi pasien dan kesehatan masyarakat.

BAB II

RUANG LINGKUP

A. RUANG LINGKUP PELAYANAN GIZI

Ruang lingkup pelayanan gizi rumah sakit meliputi :

1. Pelayanan gizi rawat jalan

Pelayanan gizi rawat jalan meliputi kegiatan konseling individual seperti pelayanan konseling gizi dan dietetik di unit rawat inap, atau pelayanan penyuluhan berkelompok bagi pasien dengan masalah gizi yang sama.

Mekanisme pasien berkunjung untuk mendapatkan asuhan gizi di rawat jalan adalah sebagai berikut :

a. Pasien datang ke ruang konseling gizi dengan membawa surat rujukan dokter dari poliklinik yang ada di rumah sakit, atau dari rumah sakit lain, atau tanpa surat rujukan dokter (APS).
b. Dietisien melakukan pencatatan di buku register konseling gizi dan di status pasien.
c. Dietisien melakukan asesmen gizi berupa anamnesis riwayat makan, riwayat personal dan membaca hasil pemeriksaan lab dan fisik klinis (bila ada). Kemudian menganalisa semua data asesmen gizi.
d. Dietisien menetapkan terapi gizi.
e. Dietisien memberikan intervensi gizi berupa edukasi dan konseling dengan langkah menyiapkan dan mengisi leaflet sesuai penyakit dan kebutuhan gizi pasien serta menjelaskan makanan yang dianjurkan dan yang dilarang, cara pemasakan dan lain-lain yang disesuaikan dengan pola makan dan keinginan serta kemampuan pasien.
f. Bila diperlukan, maka pasien dianjurkan untuk melakukan kunjungan ulang untuk mengetahui keberhasilan serta dilakukan monitoring dan evaluasi.
g. Untuk pelaksanaan penyuluhan kelompok, dilakukan sesuai dengan jadwal dari tim PKMRS RumahSakit Daerah Kalabahi, dengan mekanisme :
    - Menentukan materi sesuai kebutuhan
    - Membuat materi yang akan disajikan
    - Merencanakan media yang akan digunakan

- Persiapan alat bantu/media
- Pelaksanaan penyuluhan dengan mekanisme :
  - Peserta mengisi daftar hadir.
  - Menyampaikan materi penyuluhan
  - Tanya jawab

2. Pelayanan Gizi Rawat Inap

Mekanisme pelayanan gizi rawat inap adalah sebagai berikut :

a. Skrining gizi

Skrining gizi dilakukan pada semua pasien pada awal masuk, selambat-lambatnya dalam waktu 2 x 24 jam oleh ahli gizi. Skrining gizi bertujuan untuk mengidentifikasi pasien yang beresiko malnutrisi atau kondisi khusus, dan digunakan untuk penetapan order diet.

b. Ahli gizi melakukan penetapan resiko nutrisional dengan memperhatikan beberapa hal yakni :

- Berat badan (BB) dan tinggi badan (TB) yang secara aktual telah diukur oleh perawat atau secara *recall*/bertanya kepada pasien atau keluarga pasien (untuk pasien yang tidak bisa diukur berat badan dan tinggi badannya), atau dilakukan pengukuran Lingkar Lengan Atas (LILA) untuk menganalisis status gizi pasien (IMT, RBW dan %LILA).
- *Food recall* untuk mengetahui apakah terjadi penurunan konsumsi pasien selama satu minggu yang lalu atau kurang lebih tiga bulan yang lalu.
- Melakukan penilaian global subjektif dari status nutrisi, untuk penetapan resiko malnutrisi.
- Menyimpulkan penetapan resiko malnutrisi sesuai dengan hasil pemeriksaan, disesuaikan dengan kriteria :
  - Alimentasi baik : A
  - Diragukan malnutrisi sedang : B
  - Malnutrisi berat : C

c. Bila hasil skrining menunjukkan pasien beresiko malnutrisi, dietisien melakukan monitoring dan evaluasi setidaknya setiap 2 hari sekali.

d. Ahli gizi menjelaskan kepada pasien, diet yang akan dikonsumsi selama pasien dirawat di rumah sakit, bila pasien menjalankan diit khusus, maka ahli gizi akan

langsung menjelaskan makanan apa yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi selama masa perawatan.

e. Ahli gizi mencatat dalam form asuhan gizi, lembar asuhan terintegrasi dan lembar edukasi.

f. Ahli gizi yang berkompeten melaksanakan pengkajian fungsional lanjut untuk pasien yang beresiko nutrisi/malnutrisi dengan syarat-syarat sesuai keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1306/Menkes/SK/XII/2001 yaitu :

- Seseorang yang lulus dari pendidikan gizi yang terintegrasi.
- Seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang, memiliki kode etik dan mempunyai sifat melayani masyarakat.
- Untuk Sarjana 1 Gizi atau Diploma III Gizi ditambah pendidikan profesi (internship) dan ujian profesi serta dinyatakan lulus kemudian.
- Untuk Diploma III Gizi dinyatakan lulus dalam ujian kompetensi (Ahli Gizi yang teregistrasi).
- Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) di mana merupakan bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada tenaga kesehatan yang diregistrasi serta memiliki sertifikat kompetensi.

g. Dalam melaksanakan pengkajian lanjut, ahli gizi mempertimbangkan beberapa hal, yaitu :

- Antropometry, biokimia, klinis dan pola makan pasien.
- Melakukan penetapan diet (preskripsi diet) yang bertujuan untuk menentukan kebutuhan fungsional sesuai dengan hasil pengkajian lanjut.
- Melakukan monitoring dan evaluasi untuk pasien yang beresiko malnutrisi (food recall/intake makanan, biokimia, klinis) setiap 2 x 24 jam.
- Melakukan edukasi, penyuluhan dan konsultasi gizi sesuai dengan hasil pengkajian sebagai suatu proses skrining identifikasi pasien beresiko nutrisi/malnutrisi yang terbukti pada catatan pelayanan terintegrasi dan lembar edukasi.
- Melakukan koordinasi kepada dokter yang merawat dan perawat.

3. Produksi dan distribusi makanan

a. Menyusun Buku Peraturan Pemberian Makanan Rumah Sakit

- Penyusunan standar makanan rumah sakit berdasarkan kebutuhan terapi nutrisi untuk berbagai penyakit.
- Penyusunan menu makanan disesuaikan dengan iklim, budaya dan kebiasaan makan pasien.
- Pemberian diit kepada pasien sesuai rekomendasi dari dokter pemeriksa.

b. Mencatat kebutuhan diit rawat inap
   - Kebutuhan diit dicatat berdasarkan jumlah pesanan diit dari ruang rawat inap.
   - Kebutuhan tersebut direkap dalam form permintaan makanan pasien.

c. Menyusun formula menu dan perencanaan kebutuhan bahan makanan.
   - Penyusunan siklus menu untuk pasien dilakukan untuk 7 hari.
   - Perencanaan kebutuhan bahan makanan harian disesuaikan dengan jumlah pasien.

d. Menyusun anggaran belanja Unit Gizi.
   - Penyusunan anggaran dilakukan satu tahun sekali setiap bulan September, dengan acuan RKAP tahun sebelumnya ditambahkan 20%.
   - Pembuatan uang muka dilakukan dalam 4 tahap setiap satu bulan.
   - Anggaran didistribusikan sesuai dengan kebutuhan.

e. Melakukan pengadaan bahan makanan, penerimaan, penyimpanan dan distribusi bahan makanan.
   - Pemesanan bahan makanan disesuaikan dengan jumlah pasien dan menu.
   - Bahan makanan yang datang dicek sesuai dengan permintaan dan spesifikasi.
   - Penyimpanan bahan makanan dikelompokkan sesuai dengan jenis dan masa kadaluarsa.
   - Pendistribusian bahan makanan sesuai dengan permintaan dari setiap bagian.
   - Penerimaan dan pengeluaran bahan makanan dicatat dalam kartu stok.

f. Mengelola produksi dan distribusi makanan bagi pasien sesuai kebutuhan.
   - Produksi Makanan

     Pengolahan makanan pasien dan dokter dilakukan oleh petugas produksi sesuai dengan menu dan jumlah permintaan.
   - Distribusi Makanan
     - Dilakukan dengan sistem sentralisasi.

- Pendistribusian makanan pasien dilakukan oleh petugas penyaji sesuai dengan menu, diit, jumlah dan waktu yang sudah ditentukan.

4. Penelitian dan Pengembangan Gizi Terapan

Penelitian dan pengembangan gizi terapan dilakukan untuk meningkatkan kemampuan guna menghadapi tantangan masalah gizi yang kompleks. Tujuan dilakukan penelitian dan pengembangan gizi terapan adalah untuk mencapai kualitas pelayanan gizi rumah sakit secara berdaya guna dan berhasil guna.

Sasaran kegiatan adalah pelayanan gizi di ruang rawat inap dan penyelenggaraan makanan.

Kegiatan yang dilakukan adalah :

- Pemantauan makanan sisa.
- Angka keterlambatan pemberian makanan pasien.
- Angka kesalahan pemberian diet pasien.

5. Landasan Hukum

Sebagai acuan dan dasar pertimbangan dalam penyelenggaraan pelayanan gizi di rumah sakit diperlukan peraturan perundang-undangan pendukung (*legal aspect*).

Beberapa ketentuan perundang-undangan yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
2. Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
3. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1204/Menkes/SK/PER/XI/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit.
4. Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit, Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2013.

B. KUALIFIKASISUMBER DAYA MANUSIA.

Dalam melaksanakan pelayanan instalasi gizi rumah sakit Daerah Kalabahi dipinpin oleh kepala unit gizi.Distribusi ketenagaan di instalasi gizi disesuaikan dengan kualifikasi dan beban kerja yang ada untuk distribusi ketenagaan di Unit Gizi disebutkan dalam tabel sesuai dengan tugas masing-masing karyawan.

- **Nutrisionis**

No	Nama	Status pegawai	Pendidikan	Masa kerja	Pelatihan yang pernah di ikuti	Jabatan saat ini
1	Elkar M Fobia S.GZ	PNS	S1.Gizi	4 Tahun		Ka.Unit
2	Litvrina Barus S.Gz	PNS	S1.Gizi	1 Tahun	-	Nutrisionis
3	Sinticke Manikameng,S.km	PNS	GIZI	1 Tahun	-	Nutrisionis
4	Yasinta Manu Amd.Gz	PNS	GIZI	1 Tahun	-	Nutrisionis
5	Yohana Pesang Amd.Gz	PNS	GIZI	9 Tahun	-	Nutrisionis
6	Zabrina N Sape Amd.Gz	PNS	GIZI	4 Tahun	-	Nutrisionis
7	Maria Ataula Amd. Gz	P3K	GIZI	12 tahun	-	Nutrisionis
8	Debora Maata Amd .GZ	P3K	Gizi	2 Tahun	-	Nutrisionis
9	Agustina C.Bolugolu S.gz	P3K	GIZI	2 Tahun	-	Nutrisionis
10	Ade Rafael Haetukas, S. Gz	P3K	GIZI	4 Tahun	-	Nutrisionis
11	Tryanti N Karpada Amd . Gz	P3K	GIZI	2 Tahun	-	Nutrisionis
12	Margareta Peni Amd.Gz	P3K	GIZI	2 Tahun	-	Nutrisionis
13	Maria A.E. Elunaju	Honorer	GIZI	2 Bulan	-	Nutrisionis
14	Moh Bayi Daing S.Tr.Gz	Honor	GIZI	4 Tahun	-	Nutrisionis
15	Rita Delina Sabaat Amd,GZ	Honor	GIZI	2 Tahun	-	Nutrisionis

- **Pramusaji.**

No	Nama	Status pegawai	Pendidikan	Masa kerja	Pelatihan yang pernah di ikuti	Jabatan sat ini
1	Daud Olidela	P3K	SMA	16 tahun	-	Pramusaji
2	Soni L. Klakik	PW	SMA	9 tahun	-	Pramusaji
4	Adianus Bolingsang	PW	SMA	3 tahun	-	Pramusaji
5	Nofrianus Tellu	PW	SMA	4 Tahun	-	Pramusaji
6	Farida Subang	PW	SMA	4 Tahun	-	Pramusaji
5	Jiska Loisa Marokang	PW	SMA	4 Tahun	-	Pramusaji

- **Pramumasak.**

No	Nama	Status pegawai	Pendidikan	Masa kerja	Pelatihan yang pernah di ikuti	Jabatan saat ini
1	Masa Erpina Saku	PNS	SMA	1 Tahun	-	Pramumasak
2	Roslintje A. Beli	PNS	SMA	10 Bulan	-	Pramumasak
3	Norlinda CHR Duka	PW	SMA	12 Tahun	-	Pramumasak
4	Debora Salmai	PW	SMA	11Tahun	-	Pramumasak
5	Welmince maniley	PW	SKKA	7Tahun	-	Pramumasak
6	Sance M .Oko	PW	SMA	5 tahun	-	Pramumasak
7	Dorkas Maro	P3K	SMA	5 tahun	-	Pramumasak
8	Gloria Walitung	PW	SKKP	4 Tahun	-	Pramumasak
9	Halima Abubakar	PW	SMP	8 tahun	-	Pramumasak
10	Bertha Molina	PW	SMA	17 tahun	-	Pramumasak

11	**Agustina Bot au**	**P3K**	**SMA**	**1 Tahun**	**-**	**Pramumasak**
12	**Nursanty Adang**	**P3K**	**SMA**	**6 Tahun**	**-**	**Pramumasak**

C. DISTRIBUSI KETENAGAAN

Kepala Unit Gizi membawahi penanggung jawab gizi, administrasi, penanggung jawab produksi, distribusi . Penanggung jawab gizi bertanggung jawab terhadap pelaksanaan konsultasi gizi di Instalasi Rawat Inap maupun di Instalasi Rawat Jalan dan seluruh proses produksi makanan pasien, penanggung jawab administrasi bertanggung jawab terhadap ketersediaan bahan makanan di gudang basah maupun gudang kering, serta terhadap semua kegiatan administrasi, termasuk kebutuhan karyawan akan lembur dan cuti. Penanggung jawab produksi bertanggung jawab terhadap proses produksi makanan untuk pasien di Instalasi Rawat Inap . Penanggung jawab distribusi, bertanggung jawab terhadap pelaksanaan distribusi makanan dan snack untuk pasien . Unit Gizi terdiri dari 27 orang, yang dibagi menjadi 3 shift.

D. PENGATURAN JAGA

Unit Gizi Rumah Sakit Daerah Kalabahi melayani mulai jam 6 pagi sampai jam 8 malam, selama 7 hari. , dinas harus diatur sedemikian rupa sehingga masing-masing karyawan memiliki waktu libur. Waktu libur yang ada adalah sejumlah hari minggu dan hari libur dalam satu bulan.

Pembagian petugas diatur menjadi tiga shift .. Petugas pagi sebanyak 12 orang, petugas siang sebanyak 7 orang. Petugas Maslam 4 orang.

Pembagian jam kerja di Instalasi Gizi :

- Karyawan di bagian produksi
  - Shift pagi : 07.00 – 13.30
  - Shift siang : 13.30 – 19.00
  - Shift malam : 19.00 – 07.00
- Karyawan di bagian distribusi
  - Shift pagi : 07.00 – 13.30
  - Shift siang : 13.30 – 19.00
  - Shift malam : 19.00 – 07.00

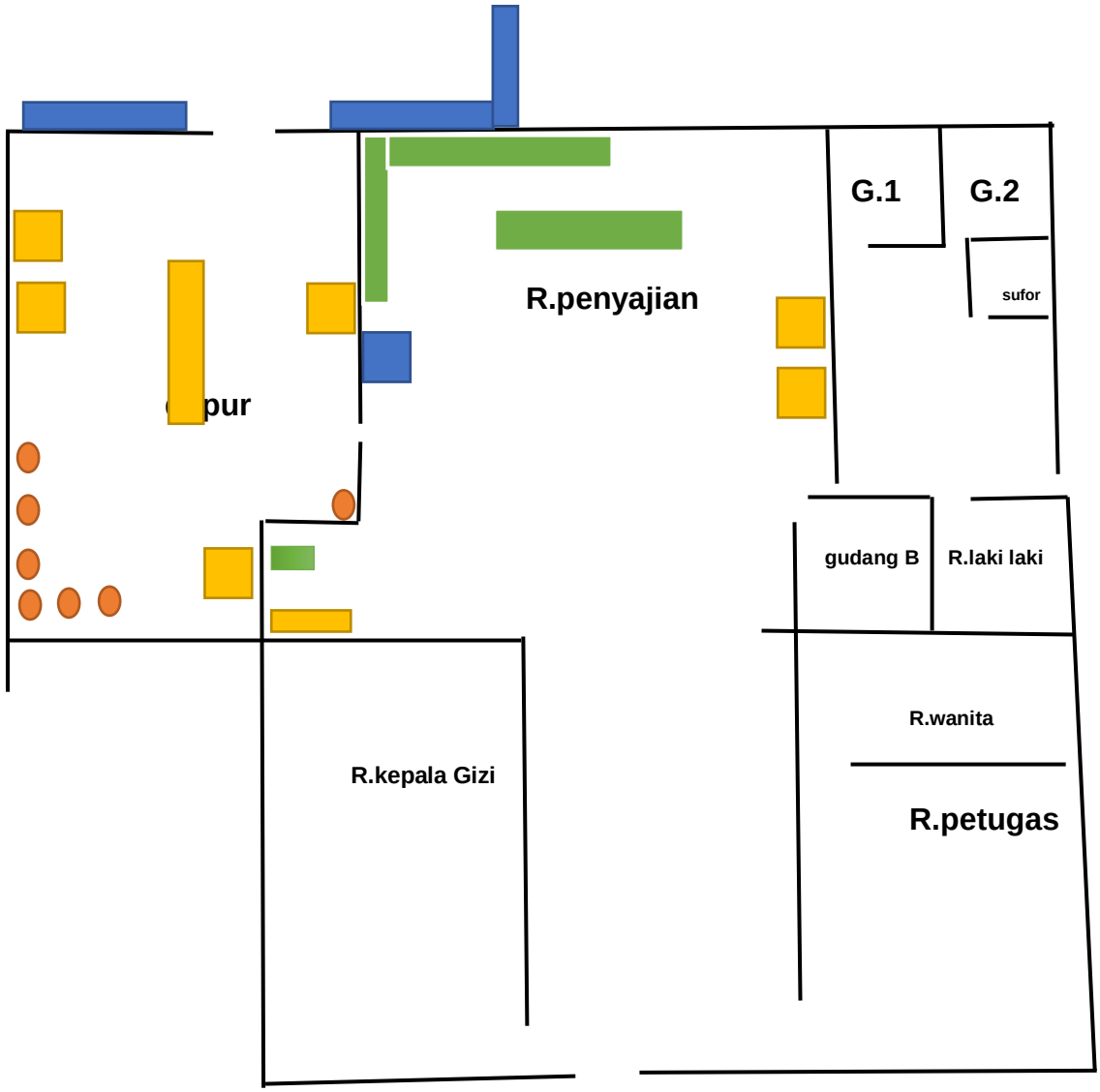
- Ahli Gizi
  - Shift pagi : 07.00 – 13.30
  - Shift siang : 13.30 – 19.00
  - Shift malam : 19.00 – 07.30
- Petugas Administrasi : 07.00 – 13.30

  Kepala Unit Gizi : 07.00 – 13.30

BAB III

DENAH DAN STANDAR FASILITAS UNIT GIZI

A. DENAH RUANG

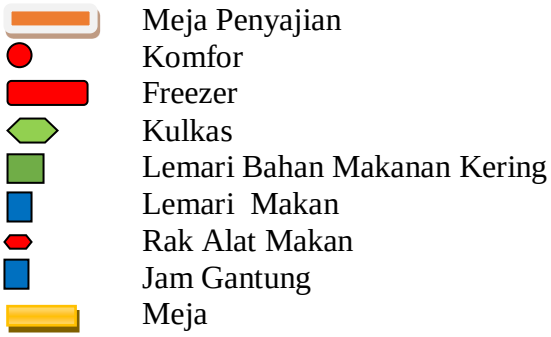


Gambar 3.1. Denah Instalasi Gizi RSD Kalabahi

Keterangan :

A : Ruang Bahan Makanan Kering
B : Ruang Penyimpanan Alat
C : Kamar Ganti Pria
D : Kamar Ganti Wanita

Lemari



Meja Penyajian
Komfor
Freezer
Kulkas
Lemari Bahan Makanan Kering
Lemari Makan
Rak Alat Makan
Jam Gantung
Meja

B. STANDAR FASILITAS

Agar kegiatan pelayanan gizi di rumah sakit berlangsung dengan optimal, maka perlu didukung dengan sarana, peralatan dan perlengkapan yang memadai baik untuk rawat jalan, rawat inap maupun di Instalasi pelayanan gizi.Fasilitas ruang dan peralatan yang tersedia di Unit Gizi Rumah Sakit Daerah Kalabahi adalah sebagai berikut :

1. Tempat penerimaan bahan makanan, tersedia fasilitas :
   - Timbangan duduk
2. Tempat penyimpanan bahan makanan yang memenuhi persyaratan kesehatan yaitu sirkulasi udara baik, penerangan baik, kelembaban tertentu, bebas serangga, bebas binatang pengerat, menurut Kemenkes Nomor 1204 tahun 2004, adapun tempat penyimpanan bahan makanan kering dan bahan makanan basah sebagai berikut :
   - Bahan makanan kering :
     a. Terdapat gudang dengan ukuran 3 m x 2.5 m.
     b. Bahan makanan tidak diletakkan di bawah saluran/pipa air (air bersih maupun limbah) untuk menghindari terjadi kebocoran.
     c. Tidak ada drainase di sekitar gudang makanan.
     d. Semua bahan makanan disimpan pada lemari.
     e. Suhu gudang bahan makanan kering dijaga kurang dari 22°C
     f. Penempatan bahan makanan ditata secara rapi dan ditata sesuai dengan tanggal kedatangan dan tanggal kadaluarsa, serta tidak padat untuk menjaga sirkulasi udara.

- Bahan makanan basah atau lunak disimpan ke dalam freezer atau almari pendingin dengan suhu penyimpanan menurut jenis makanannya yang tercantum pada tabel :

  Tabel 3.1. Suhu Penyimpanan Bahan Makanan

Bahan Makanan	Lama Waktu Penyimpanan		
	< 3 hari	≤ 1 minggu	≥ 1 minggu
Daging, ikan, udang dan hasil olahannya	-5 – 0°C	-10 - -5°C	< 10°C
Telur, buah dan hasil olahannya	5 – 7°C	-5 – 0°C	< 5°C
Sayur, buah dan minuman	10°C	10°C	10°C
Tepung dan biji-bijian	25°C	25°C	25°C

3. Ruang peracikan bahan makanan, tersedia fasilitas :
   - Blender bumbu
   - Pisau
   - Parang
   - Talenan
4. Ruang persiapan bahan makanan

   Tempat untuk mempersiapkan bahan makanan dan bumbu meliputi kegiatan membersihkan, mencuci, mengupas, menumbuk, menggiling, memotong, mengiris dan lain-lain sebelum bahan makanan dimasak. Terdapat 1 meja kerja stainless stell, meja pemotong daging, mixer, blender, penggiling dari batu dan wastafel pencucian bahan makanan.
5. Tempat pemasakan
   - Tempat pemasakan menjadi satu tempat antara makanan biasa dan makanan diet.
   - Ruang pengolahan snack terpisah dari ruang pengolahan makanan.
   - Setelah proses pemasakan selesai, makanan dipindahkan ke dalam ruang penyaji.
   - Tempat pemasakan terdiri dari 2 kompor kecil masing-masing dua mata api, 4 kompor besar.

6. Tempat penyajian makanan
    - Pembagian/penyajian makanan dilakukan oleh petugas gizi.
    - Penyajian makanan dilakukan sesuai dengan pesanan menu dari ruang rawat inap.
    - Tempat untuk menyajikan makanan adalah piring, mangkuk dan ompreng stainless stell bertutup.
    - Dilakukan pengemasan dengan plastik warp sebelum didistribusikan ke rawat inap.
    - Terdapat 2 meja kerja stainless stell, 2 lemari kaca tempat penyimpanan bahan makanan kering dan makanan masak, *washtafel*.
    - Petugas penyaji membawa makanan ke rawat inap dengan menggunakan *trolly* dan menyajikan kepada pasien sesuai dengan pesanan dari ruang rawat inap.
7. Tempat pencucian alat
    - Tersedia 2 bak tempat pencucian peralatan dapur.
    - Tersedia air dingin dan air panas
    - Tersedia 2 bak pencucian peralatan, yang satu digunakan untuk pencucian alat makanan menular.
    - Pencucian alat makan menggunakan sabun cair sunlight.
    - Pencucian peralatan masak menggunakan sabun cair sunlight.
8. Tempat penyimpanan peralatan
    - Penyimpanan peralatan makan pasien dilakukan di ruang penyaji dengan menggunakan rak piring terbuka.
    - Penyimpanan peralatan masak di ruang pencucian alat dengan menggunakan rak terbuka.
9. Tempat pembuangan sampah
    - Menggunakan tempat sampah tertutup dan berlapis kantong plastik hitam yang disiapkan di masing-masing bagian pengolahan.
    - Sampah diambil oleh petugas masak setiap kali tempat sampah penuh, untuk dibuang di tempat pembuangan sementara.
10. Ruang fasilitas pegawai
    - Terdapat ruangan untuk tempat ganti pakaian pegawai.
11. Kamar mandi
    - Terdapat 1 buah kamar mandi untuk digunakan oleh pegawai.

- Tersedia air bersih.
- Tersedia gayung.

12. Ruang perkantoran dan administrasi
    - Terdapat meja kursi
    - Lemari buku
    - Komputer dan printer
    - Tersedia papan informasi
13. Tempat cuci tangan
    - Tersedia handwash dan washtafel yang dilengkapi dengan sabun cair di ruang penyaji.
14. Ruang/tempat penyuluhan dan konsultasi gizi
    - Penyuluhan gizi kepada keluarga pasien dan kelompok masyarakat dilakukan oleh ahli gizi di ruang konsultasi gizi .
    - Konsultasi gizi untuk pasien rawat inap, dilakukan oleh ahli gizi di ruang rawat inap.
    - Tersedia leaflet dan food model sebagai sarana pendukung kegiatan konsultasi dan penyuluhan gizi.

- Standar fasilitas pendukung
    1. Fasilitas/ peralatan untuk konsultasi gizi/ penyuluhan diit, terdiri dari :
        - Timbangan badan
        - Timbangan bayi
        - Alat pengukur tinggi badan
        - Food model (1 set)
        - Daftar bahan makanan penukar
        - Leaflet (ibu hamil, ibu menyusui, tumbuh kembang bayi dan balita, balita gizi kurang, rendah kalori, TKTP, rendah garam, rendah cholesterol, rendah purin, rendah protein, dm, rendah lemak, jantung, lambung,)
    2. Fasilitas penyimpanan bahan makanan
        - Lemari pendingin 2 buah, untuk penyimpanan sayur, bumbu, buah dan bahan makanan setengah jadi.
        - Freezer 1 buah untuk penyimpanan bahan makanan mentah (daging, ayam dan ikan).

3. Fasilitas penerimaan bahan makanan.
    - Tersedia timbangan bahan makanan.
    - Tersedia alat pemeriksa kualitas telur.
4. Fasilitas distribusi.
    - Tersedia trolly tertutup untuk distribusi di ruang rawat inap.
    - Tersedia baki dan peralatan makan sesuai kelas perawatan.
5. Tersedia alat pelindung diri.
    - Celemek
    - Topi/penutup kepala
    - Masker
    - Sarung tangan dissposibble
6. Tersedia sumber air bersih.
    - Sumber air bersih sumur bor
    - Pemeriksaan kekeruhan dan pH dilakukan oleh bagian kesehatan lingkungan.
    - Hasil pemeriksaan air setiap enam bulan sekali.
7. Tersedia sumber listrik yang baik dan aman.
    - Tersedia sumber listrik yang baik dan aman, voltage yang stabil dan dapat dimonitor.
    - Sumber listrik 240 voltage.
    - Intensitas cahaya minimal 200 lux.
8. Penerangan dan ventilasi cukup
    - Tersedia penerangan/lampu di setiap bagian dalam dan luar Unit Gizi.
    - Tersediaventilasi fan dan kipas angin baling-baling yang cukup untuk membantu sirkulasi dan ventilasi ruangan.
9. Alat pemadam kebakaran
    - Tersedia 1 APAR
    - Pengecekan fungsi tabung pemadam kebakaran dilakukan oleh petugas instalasi pemeliharaan sarana, sesuai dengan jadwal pemeliharaan.

- Standar Inventarisasi Peralatan Unit Gizi

  Tersedia inventarisasi peralatan yang digunakan di Unit Gizi yang dikelompokkan sesuai dengan ruang /tempat peralatan tersebut tersedia (inventarisasi peralatan terlampir).

BAB IV
TATA LAKSANA PELAYANAN

Tata laksana kegiatan pelayanan gizi di Unit Gizi terdiri dari 4 cakupan pelayanan dengan mekanisme kerja sebagai berikut :

A. Tata Laksana Produksi dan Distribusi Makanan

1. Menyusun standar makanan rumah sakit sesuai dengan penuntun diet
   - Penyusunan standar makanan rumah sakit berpedoman pada buku penuntun diet.
   - Penyusunan menu makanan disesuaikan dengan jumlah pasien dan kondisi pasien.
   - Pemberian diet kepada pasien sesuai dengan rekomendasi dari dokter pemeriksa.
2. Menyusun kebutuhan diet pasien rawat inap
   - Kebutuhan diet disusun berdasarkan jumlah pesanan diet dari ruang rawat inap.
   - Kebutuhan tersebut direkap dalam buku permintaan makanan pasien.
   - Ahli gizi menghitung jumlah pasien yang membutuhkan terapi diet.
3. Menyusun formula, menu dan perencanaan kebutuhan bahan makanan.
   - Menyusun formula sonde bagi pasien.
   - Penyusunan siklus menu 7 hari untuk pasien. Menu standar dibedakan berdasarkan kelas, untuk kelas I, VIP, VVIP terdiri dari 1 lauk nabati dan 2 lauk hewani, mendapatkan 1 kali snack, sedangkan untuk kelas II dan III, terdiri dari 1 lauk nabati dan 1 lauk hewani, dan mendapatkan 1 kali snack.
   - Penyusunan siklus snack 7 hari.
   - Perencanaan kebutuhan bahan makanan disesuaikan dengan jumlah pasien.
4. Menyusun Anggaran Belanja Unit Gizi
   - Ahli gizi menghitung jumlah pasien .
   - Merencanakan kebutuhan bahan makanan basah dan kering.
   - Kepala Unit Gizi menyusun rencana anggaran belanja sesuai dengan kebutuhan dengan prediksi kenaikan harga pasaran sebesar 10% dari rencana anggaran tahun sebelumnya.
5. Melakukan pengadaan bahan makanan, penerimaan, penyimpanan dan distribusi makanan.
   - Pemesanan bahan makanan disesuaikan dengan jumlah permintaan dari masing-masing bagian.

- Bahan makanan yang datang dicek sesuai dengan permintaan dan spesifikasi.
- Penyimpanan bahan makanan dikelompokkan sesuai dengan jenis dan masa kadaluwarsa.
- Pendistribusian bahan makanan sesuai dengan permintaan setiap bagian.
- Penerimaan dan pengeluaran bahan makanan dicatat dalam kartu stok.

6. Mengelola produksi dan distribusi makanan bagi pasien rawat inap sesuai dengan kebutuhan.
7. Distribusi makanan

   Pendistribusian makanan dilakukan oleh petugas pramusaji sesuai dengan pesanan menu, diit, jumlah dan jadwal distribusi yang telah ditentukan.

   - Jadwal pemberian makanan pasien adalah sebagai berikut :
     - Makan pagi : 05.30- 06. 30
     - Ekstra bubur kacang ijo pagi : 09.00- 10.00
     - Makan siang : 11.30- 12.30
     - Makan sore : 17.30- 18 .30

B. Tata Laksana Pelayanan Gizi Ruang Rawat Inap

1. Menyusun rancangan diit rawat inap sesuai dengan keadaan pasien dan penyakitnya.
2. Ahli gizi mengetahui adanya pasien baru yang bermasalah dengan nutrisi dari perawat ruangan.
3. Ahli gizi melakukan kunjungan gizi serta melakukan pengkajian awal kepada pasien yang bermasalah dengan nutrisi dengan tujuan melakukan assesmen nutrisi dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam.
4. Ahli gizi melakukan penetapan resiko nutrisional dengan mempertimbangkan beberapa hal :
   - Berat Badan (BB) dan Tinggi Badan (TB) yang secara aktual telah diukur oleh perawat atau secara *recall* bertanya kepada pasien atau keluarga pasien (untuk pasien yang tidak dapat dilakukan pengukuran berat badan dan tinggi badan) atau dilakukan pengukuran Lingkar Lengan Atas (LILA), untuk menganalisis status gizi pasien (IMT, RBW, dan % Lila).
   - *Food Recall*untuk mengetahui apakah terjadinya penurunan konsumsi pasien selama satu minggu yang lalu atau kurang lebih tiga bulan yang lalu.

- Menyimpulkan penetapan resiko nutrisional.
- Ahli gizi yang berkompeten akan melaksanakan pengkajian fungsional lanjut untuk pasien yang beresiko nutrisi/malnutrisi yaitu :
  - Seseorang yang lulus dari pendidikan gizi yang terintegrasi.
  - Seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang, memiliki kode etik dan bersifat melayani masyarakat.
  - Untuk Diploma III Gizi dinyatakan lulus dalam uji kompetensi (Ahli Gizi yang teregistrasi).
  - Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) di mana merupakan bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada tenaga kesehatan yang diregistrasi serta memiliki sertifikat kompetensi.
- Ahli gizi melaksanakan pengkajian gizi terhadap pasien-pasien yang bermasalah dengan nutrisi, yaitu pasien yang tidak mau makan, pasien malnutrisi dan pasien yang menjalankan diit khusus.
- Dalam melaksanakan pengkajian lanjut, ahli gizi mempertimbangkan beberapa hal :
  - Antropometry, biokimia, klinis, dan pola makan pasien.
  - Menentukan diagnosa gizi sesuai dengan pengkajian yang dilakukan.
  - Melakukan penetapan diet (preskripsi diet) yang bertujuan untuk menentukan kebutuhan fungsional sesuai dengan hasil pengkajian lanjut.
  - Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pasien yang bermasalah dengan nutrisi (food recall, intake, biokimia) setiap 3 hari sekali.
  - Melakukan edukasi, penyuluhan dan konsultasi gizi sesuai dengan hasil pengkajian sebagai suatu proses skrinning identifikasi pasien yang bermasalah dengan nutrisi yang terbukti pada pencatatan di dalam lembar asuhan gizi.
  - Melakukan koordinasi terhadap dokter yang merawat dan dengan perawat ruangan.

5. Melakukan monitoring dan evaluasi pasien di ruang rawat inap
   - Ahli gizi melakukan monitoring dan evaluasi pasien yang bermasalah dengan nutrisi dengan cara kunjungan setiap 2 hari sekali.
   - Ahli gizi mengobservasi pola makan pasien selama di rumah sakit.

- Ahli gizi memberikan edukasi serta motivasi untuk tetap mematuhi dan mengkonsumsi makanan yang telah disajikan di rumah sakit.
- Bila ada pergantian diit maka dilakukan koordinasi dengan dokter pemeriksa dan perawat.

C. Tata Laksana Penyuluhan dan Konsultasi Gizi

Merencanakan dan melakukan penyuluhan atau konsultasi diit dan rujukan diit secara individual bagi pasien rawat inap .

1. Penyuluhan Gizi Rawat Inap
    - Ahli gizi melakukan penyuluhan di ruang rawat inap dilakukan sesuai dengan permintaan dari dokter yang merawat, dari pasien atau keluarga pasien, dan apabila pasien tersebut dipandang perlu untuk mendapatkan konsultasi gizi.
    - Materi yang diberikan sesuai dengan keadaan dan kondisi pasien.
    - Ahli gizi memberikan leaflet setiap setelah melakukan konsultasi gizi yang pertama kali.
    - Diet yang diberikan antara lain diet TKTP, RG, DM, dan lain sebagainya.
    - Penyuluhan gizi rawat inap dapat dilakukan bersama tim edukasi Rumah Sakit Daerah Kalabahi.
2. Konsultasi Gizi Rawat Inap
    - Ahli gizi memberikan informasi di ruang rawat inap apabila ada permintaan dari dokter yang merawat pasien atau permintaan dari pasien dan keluarga pasien.
    - Ahli gizi melakukan kunjungan ke ruang rawat inap untuk melakukan konsultasi gizi.
    - Ahli gizi memberikan konsultasi gizi dan memberikan leaflet kepada pasien sebagai catatan diet yang harus dijalankan.
    - Setelah memberikan konsultasi kepada pasien dan keluarganya, ahli gizi melakukan entry data, entry hasil konsultasi dan cetak nota biaya konsultasi, yang diserahkan kepada petugas rekam medis di rawat inap.
    - Ahli gizi mengisi lembar asuhan gizi yang berada di dalam status pasien.
    - Ahli gizi mencatat pasien yang mendapatkan konsultasi gizi ke dalam buku register konsultasi gizi.
3. Konsultasi Gizi Rawat Jalan

- Ahli gizi melakukan konsultasi gizi di poliklinik apabila ada permintaan dari dokter yang merawat pasien, pasien yang berobat di poliklinik atau permintaan dokter luar rumah sakit.
- Ahli gizi memberikan konsultasi gizi dengan memperhatikan diagnose pasien, kondisi fisik, klinis, dan pemeriksaan laboratorium.
- Ahli gizi mencatat data-data pasien ke dalam buku register konsultasi gizi, dengan memberi kode rawat jalan.
- Ahli gizi memberikan penjelasan diet kepada pasien dan keluarga pasien, serta memberikan leaflet sebagai catatan sesuai dengan diet yang harus dijalankan oleh pasien.
- Ahli gizi memberikan kesempatan kepada pasien untuk bertanya mengenai diet yang telah dijelaskan.
- Ahli gizi mencatat diet yang diberikan kepada pasien ke dalam status rawat jalan pasien.
- Ahli gizi mencatat ke dalam buku register gizi.
- Ahli gizi melaporkan kepada kasir poli umum untuk proses administrasi bagi pasien yang menjadi tanggungan perusahaan.

BAB V

TATA LAKSANA PELAYANAN GIZI TERINTEGRASI

A. Proses Terapi Gizi

Tahapan langkah proses terapi gizi dari skrininng/penapisan, kajian, diagnosis medis dan diagnosisi gizi (penentuan masalah gizi), formulasi terapi (intervensi gizi), pelaksanaan terapi, pemantauan dan evaluasi terapi, penyususnan rencana ulang terapi atau penghentian terapi. Rangkaian langkah tersebut bertujuan untuk memberi dampak terapi yang optimal bagi pasien dan mempunyai keefektifan biaya.

1. Skrinning Gizi

Tahapan pelayanan gizi rawat inap diawali dengan skrining/penapisan gizi oleh perawat ruangan dan penetapan diet awal oleh dokter. Skrining gizi bertujuan untuk mendidentifikasi pasien yang berisiko, tidak berisiko malnutrisi atau kondisi khusus. Kondisi khusus yang dimaksud adalah pasien dengan kelaianan metabolik, hemodialisis, anak, geriatri, kanker dengan kemoterapi/radiasi, luka bakar, pasien dengan imunitas menurun, sakit kritis dan sebagainya. Idealnya skrinning gizi dilakukan pada pasien baru1 x 24 jam setelah pasien masuk rumah sakit. Metode skrinning sebaiknya singkat cepat, dan disesuaikan dengan kondisi rumah sakit.

Bila hasil skrining gizi menunjukkan pasien berisiko malntrisi, maka dilakukan pengkajian/assesmen gizi dan dilakukan dengan langkah-langkah. Proses Asuhan Gizi Terstandar(PAGT) oleh dietisien. Pasien dengan status gizi baik atau tidak berisiko malnutrisi, dianjurkan dilakukan skrining ulang setelah 1 minggu. Jika hasil skrining ulang berisiko malnutrisi maka dilakukan Proses Asuhan Gizi Terstandar.

2. Proses Asuhan Gizi Terstandar (PAGT)

Proses Asuhan Gizi Terstandar dilakukan pada pasien yang berisiko kurang gizi, mengalami kurang gizi atau kondisi khusus dengan penyakit tertentu, proses ini merupakan serangkaian kegiatan yang berulang (siklus).

a. Asesmen/Pengkajian Gizi

Asesmen dilakukan dalam 5 kategori yaitu :

1) Anamnesis Rawat Gizi

Anamnesis riwayat gizi adalah data meliputi asupan makanan termasuk komposisi, pola makan, diit saat ini dan data lain yang terkait. Selain itu

diperlukan pula data kepedulian pasien terhadap gizi dan kesehatan, aktifitas fisik dan olahraga dan ketersediaan makanan di lingkungan klien. Gambaran asupan makakak dapat digali melaluai anamnesis kualitatif dan kuantitatif.

2) Biokimia

Meliputi pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan yang berkaitan dengan status gizi, status metabolik dan gambaran fungsi organ yang berpengaruh terhadap timbulnya gizi, status metabolik dan gambaran fungsi organ yang berpengaruh terhadap timbulnya masalah gizi.

3) Antropometri

Merupakan pengukuran fisik individu yang dilakukan dengan berbagai cara, antar lain pengukuran Tinggi Badan (TB), pengukuran Berat Badan (BB). Pada kondisi tinggi badan tidak dapat diukur dapat digunakan. Panjang Badan (PB), Tinggi Lutut (TL), Rentang Lengan atau separuh rentang lengan. Pengukuran lain seperti Lingkar Lengan Atas (LiLA), tebal lipat kulit, lingkar kepala, dan lain sebagainya dapat dilakukan.

Penilaian status gizi dilakukan dengan membandingkan beberapa ukurantersebut misalnya Indeks Masa tubuh (IMT). Pemeriksaan fisik yang paling sederhanuntuk melihat status gizi pada pasien rawat inap adalah BB. BB pasien sebaiknyadicatat saat pasien masuk dirawat dan dilakukan pengukuran BB secara periodik selamapasien dirawat minimal 7 hari.

4) Pemeriksaan Fisik/Klinis

Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui adanya kelainan kinis yang berkaitan dengan gangguan gizi atau dapat menimbulkan masalah gizi. Contoh beberapa data pemeriksaan fisik terkait gizi antara lain edema, asites, kondisi gigi geligi, masa otot yang hilang, lemak tubuh yang menumpuk

5) Riwayat Personal

Data riwayat personal meliputi :

- Riwayat obat-obatan yang digunakan dan suplemen yang dikonsumsi.
- Sosial budaya, meliputi sosial ekonomi, budaya, kepercayaan/agama, situasi rumah, dukungan pelayanan kesehatan dan sosial.
- Riwayat penyakit, meliputi keluhan utama terkait masalah gizi, riwayat penyakit dahulu dan sekarang, riwayat pembedahan penyakit kronik atau risiko komplikasi, riwayat penyakit keluarga, stastus kesehatan mental serta kemampuan kognitif.

- Data umum paisen antara lain umur, pekerjaan dan tingkat pendidikan.

b. Diagnosa Gizi

Pada langkah ini dicari pola hubungan antara data yang terkumpul dan kemungkinan penyebabnya. Kemudian memilah masalah gizi yang spesifik dan menyatakan masalah gizi secara singkat dan jelas menggunakan terminologi yang ada. Penulisan diagnosa gizi terstruktur dengan konsep PES atau Problem, Etiologi dan Signs/Symptoms. Diagnosisi gizi dikelompokan menjadi tiga (3) domain, yaitu

1) Domain Asupan

Domain asupan adalah masalah aktual yang berhubungan dengan asupan energy, zat gizi, cairan, substansi bioaktif dari makanan baik yang melalui oral maupun parenteral dan enteral.

2) Domain Klinis

Domain klinis adalah masalah gizi yang berkaitan dengan kondisi atau fisik/fungsi organ.

3) Domain Perilaku/Lingkungan

Domain perilaku/lingkungan adalah domain maslah gizi yang berkaitan dengan pengetahuan, perilaku/kepercayaan, lingkungan fisik dan akses keamanan makanan.

c. Intervensi Gizi

Terdapat 2 komponen intervensi, yaitu :

1. Perencanaan Intervensi

Disusun dengan merujuk pada diagnosis gizi yang ditegakkan. Output dari intervensi ini adalah tujuan yang terukur, preskripsi diit dan strategi pelaksanaan (implementasi).

Perencanaan intervensi meliputi :

- Penetapan tujuan intervensi
- Preskripsi diit
- Menggambarkan rekomendasi mengenai kebutuhan energi dan zat gizi individual, jenis diit, bentuk makanan, komposisi zat gizi, frekuensi makan/jadwal pemberian diit, jalur makanan.

2. Implementasi Iintervensi

Dietisien melaksanakan dan mengkomunikasikan rencana asuhan kepada pasien dan tenaga kesehatan atau tenaga lain yang terkait. Kegiatan ini juga termasuk pengumpulan data kembali, dimana data tersebut dapat menunjukkan respon pasien dan perlu atau tidaknya modifikasi intervensi gizi.

d. Monitoring dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi terapi gizi bertujuan untuk menilai proses dan keberhasilan implementasi terapi gizi serta rencana tindak lanjut terapi. Empat (4) langkah kegiatan monitoring dan evaluasi yaitu :

1. Monitor perkembangan, antar lain : mengecek pemahaman dan ketaatan diit pasien, mengecek asupan makan, menetukan apakah intervensi dilaksanakan sesuai dengan rencana, menentukan status gizi pasien tetap/berubah, toleransi saluran cerna dan status hemodinamik serta kondisi metabolikn pasien, dan mengidentifikasi hasil pemeriksaan lain.
2. Mengukur hasil.
3. Evaluasi hasil.
4. Pencatatan dan pelaporan. Terdapat beberapa cara dokumentasi antara lain Subjektive Objektive Assesment Planning (SOAP) dan Assesment Diagnosisi Intervensi Monitoring (ADIME). Format ADIME merupak model yang sesuai dengan langkah PAGT.

e. Konseling

Tujuan konseling adalah memberikan edukasi untuk memahami dan mampu mengubah perilaku diet pasien sesuai dengan yang dianjurkan. Konseling diberikan kepada pasien dan atau keluarganya yang membutuhkan untuk mendapatkan penjelasanan tentang diet yang harus dilaksanakan oleh pasien sesuai dengan penyakit dan kondisinya. Konseling dilakukan oleh anggota tim sesuai dengan kompetensinya.

BAB VI

STANDAR MENU

A. Pola Menu di Rumah Sakit Daerah Kalabahi

Tabel 5.1. Pola Menu Harian

Jadwal Menu	Kelas			
	Utama	**I**	**II**	**III**
07.00 (Makan Pagi)	Nasi / penukar Lauk hewani Sayuran	Nasi / penukar Lauk hewan Sayuran	Nasi / penukar Lauk hewan Sayuran	Nasi / penukar Lauk hewani
10.00 (Snack)	Snack Teh+kue	Snack Bubur k.ijo	Snack Bubur k.ijo	Snack Bubur k.ijo
12.00 (Makan Siang)	Nasi / penukar Lauk hewani Lauk nabati Sayuran Lauk tambahan Buah	Nasi / penukar Lauk hewani Lauk nabati Sayuran Lauk tambahan Buah	Nasi / penukar Lauk hewani Lauk nabati Sayuran Buah	Nasi / penukar Lauk hewani Lauk nabati Sayuran Buah
17.00 (Makan Malam)	Nasi / penukar Lauk hewani Lauk nabati Sayuran	Nasi / penukar Lauk hewani Lauk nabati Sayuran	Nasi / penukar Lauk hewani Lauk nabati Sayuran	Nasi / penukar Lauk hewani Lauk nabati Sayuran

B. Standar Porsi Bahan Makanan

Tabel 5.2. Standar Porsi Bahan Makanan

NO	BAHAN MAKANAN	SATUAN	STANDAR PORSI
A. LAUK			
1	Daging sapi	gr	50
2	Daging ayam	gr	85
3	Tahu putih	gr	50
4	Tempe	gr	50
B. SAYUR			
1	Wortel	gr	50
2	Buncis	gr	50
3	Kentang	gr	50
4	Sawi hijau	gr	75
5	Kacang panjang	gr	50

6	Daun sop	gr	25
7	Bayam	gr	50
8	Kool	gr	50
9	Tomat buah	gr	50
10	Tomat sayur	gr	50
11	Kangkung	gr	75
12	Taoge	gr	75
13	Gambas	gr	50
14	Terong	gr	50
15	Ketimun	gr	50
16	Nangka muda	gr	75
17	Sledri, prei	gr	15
C. BUAH			
1	Pisang barangay	buah	1
2	Pisang susu	buah	1
3	Pisang ambon	buah	1
4	Pepaya	gr	150
5	Melon	gr	150
6	Semangka	gr	150
D. BAHAN KERING			
1	Bihun	gr	50
2	Agar-agar	gr	2.5
3	Kacang tanah	gr	25
4	Saus tomat	sdm	1
5	Maizena	Gr	20
6	Gula merah	Gr	15
7	Mentega	Gr	25
8	Meises	Gr	25
9	Macaroni	Gr	25
20	Teh	Gr	10
21	Tepung beras	Gr	25
23	Selai	Gr	15

24	Tepung maesena	Gr	50
25	Tepung kanji	Gr	25
26	Susu skim	Gr	25
E. BUMBU			
1	Bawang merah	Gr	2
2	Bawang putih	Gr	2
3	Merica	Gr	1
5	Pala	Gr	1
6	Ketumbar	Gr	1
7	Kemiri	Gr	1
9	Jahe	Gr	1
10	Daun salam	Lembar	1
11	Sere	Batang	1
12	Daun salam	Gr	1
13	Laos	Gr	1
14	Daun jeruk	Gr	1
15	Kencur	Gr	1
F. LAIN-LAIN			
1	Susu full cream	Gr	25
2	Beras	Gr	75
3	Snack	Potong	1
4	Roti tawar	Lembar	4
5	Gula pasir	Gr	25

C. Spesifikasi Bahan Makanan

Tabel 5.3. Spesifikasi Bahan Makanan

No	Nama Bahan Makanan	Spesifikasi
A. Lauk Pauk		
1	Dada ayam negeri	Bersih, segar, sedikit lemak, berat ± 700 gr/bh.
2	Paha ayam negeri	Bersih, segar, sedikit lemak, berat ± 100 gr/bh
3	Daging sapi	Sapi muda, segar, kenyal, tebal, tidak berlendir, tidak banyak lemak, tidak ada urat.
4	Ikan segar	Segar, tidak berlendir, insang merah, mata menonjol.
5	Telur ayam negeri	Segar, kulit mulus, bersih, berat maks. 16 btr/kg

6	Tempe /Tahu	Bahan dari kedelai putih, murni, segar, bersih, tidak asam, padat, kwalitas nomor satu.
B. Sayur mayur		
1	Bayam	Segar, muda, bersih
2	Buncis	Segar, muda, bersih, tidak berulat
3	Kacang panjang	Segar, muda, hijau muda, tidak berulat
4	Kangkung	Segar, muda, berakar, bersih, tidak berulat
5	Kentang	Tua, permukaan licin, segar, bersih
6	Labu siam	Segar, muda
7	Oyong /gambas	Segar, muda, tidak berulat (berat 100g/buah)
8	Daun sledri	Segar, daunnya hijau tua, batang dan akarnya bersih.
9	Daun bawang	Bersih, keras daunnya, tidak memar, garis lintang rata-rata 2cm.
10	Ketimun	Warna hijau, keras, waktu dibelah diantara biji tidak berlubang.
11	Sawi putih	Segar, tidak berulat, tidak memar
12	Sawi hijau	Segar, warna hijau muda, tidak berulat.
13	Kubis	Daun bagian luar berlingkar bulat, tidak memar, tidak berulat.
14	Bunga kol	Bagian dalam keras penuh, warna putih atau kekuningan, tidak berbintik-bintik.
15	Tomat	Warna orange sampai merah, matang, buah licin, tidak ada bagian2 yang keras, bersih.
16	Taoge	Panjang kira2 3cm, kedua biji kacang masih ada
17	Wortel	Segar, bersih, tidak berdaun, muda, besar kurang lebih 2.5 cm
18	Labu kuning	Segar, mudah.
C. Kacang-kacangan kering		
1.	Kacang hijau	Kering, padat, bersih, tanpa batu, tua, warna hijau
2.	Kacang merah	Kering,rata warnanya, bentuknya kira-kira sama besar, bersih.
D.Buah-buahan		
1.	Pepaya	Segar, masak pohon, berat minimum 2 kg/bh
2.	Pisang	Tua, matang, kulit mulus, tidak memar
3	Melon	Utuh, tidak memar, tua, matang
4	Semangka	Tua, matang, tidak memar, kulit mulus

D. Standar Pemberian Makanan di Rumah Sakit

1. Makanan Biasa

a. Nasi, Nasi tim

- Diberikan kepada pasien yang berdasarkan penyakitnya tidak memerlukan makanan khusus (diet).

- Pembagian Makanan Sehari

Tabel 5.4. Pembagian Makanan Sehari

Jam	Makanan	Berat (gr)
06.00	Nasi	150
	Lauk hewani	50
	Lauk nabati	40
	Sayuran	75
	Minyak	10
09.30	Snack	1 ptg
11.30	Nasi	150
	Lauk hewani	50
	Lauk nabati	40
	Sayuran	75
	Buah	100
	Minyak	10
17.30	Nasi	150
	Lauk hewani	50
	Lauk nabati	40
	Sayuran	75
	Minyak	10

Nilai gizi :	Energi	2292.6 kal
	Protein	75.93 gr
	Lemak	98.7 gr
	Karbohidrat	294.19 gr

- **Pembagian makanan sehari untuk anak-anak**

Tabel 5.5. Pembagian Makanan Sehari untuk Anak-anak

Pembagian Makanan Sehari		**Anak 1 – 5 th**	**Anak 6 – 12 th**
Jam	Makanan	Berat (gr)	Berat (gr)
06.00	Teh manis / gula pasir	10	10
07.00	Nasi	100	150
	Lauk Hewani	75	75
	Lauk Nabati	50	50
	Sayuran	25	50
	Minyak	10	10
09.00	Snack /bubur k.ijo	1gelas	1gelas
12.00	Nasi	100	150
	Lauk Hewani	75	75
	Lauk Nabati	50	50
	Sayuran	25	50

	Buah	75	75
	Minyak	10	10
15.00	Teh manis/gula pasir Snack	10 1 potong	10 1 potong
17.30	Nasi	100	150
	Lauk hewani	75	75
	Lauk nabati	50	50
	Sayuran	25	50
	Minyak	10	10

Nilai gizi :	Energi	1520 kal	1980 kal
	Protein	68 gr	83 gr
	Lemak	48 gr	60 gr
	Karbohidrat	230 gr	288 gr

- Kode pemesanan : Ns/ Ns Tim

2. Makanan Lunak

- Makanan lunak diberikan kepada penderita dengan kenaikan suhu badan tidak terlalu tinggi atau sebagai perpindahan dari makanan cair ke makanan biasa.
- Pembagian Makanan Lunak Sehari

Tabel 5.6. Pembagian Makanan Lunak Sehari

BB1, BB2		**Dewasa**	**Anak 1 – 5 th**	**Anak 6 – 12 th**
Jam	Makanan	Berat (gr)	Berat (gr)	Berat (gr)
06.00	Bubur beras	200	100	150
	Lauk Hewani	75	50	50
	Lauk Nabati	50	50	50
	Sayuran	50	25	50
	Minyak	10	10	10
9.30	Snack	1 ptg	1 ptg	1 ptg
11.30	Bubur beras	200	100	150
	Lauk Hewani	75	50	50
	Lauk Nabati	50	50	50
	Sayuran	50	25	50
	Buah	75	75	75
	Minyak	10	10	10
17.30	Bubur beras	200	100	150
	Lauk Hewani	75	50	50
	Lauk Nabati	50	50	50
	Sayuran	50	25	50

	Minyak	10	10	10

Nilai gizi :	Energi	1770 kal	1100 kal	1570 kal
	Protein	75 gr	38 gr	51 gr
	Lemak	97 gr	70 gr	84 gr
	Karbohidrat	141 gr	131 gr	153 gr

- Kode Pemesanan :
  BB1 : Bubur beras dengan lauk biasa
  BB2 : Bubur beras dengan lauk cacah (buah diberikan berupa jus buah).
- Pembagian Makanan Sehari / halus
  H1: Bubur Sumsum

Tabel 5.7. Pembagian Bubur Sumsum

Jam	Makanan	Berat (gr)
07.00	Tepung beras	50
	Gula lempeng	20
09.30	Snack	1 potong
11.30	Tepung beras	50
	Gula lempeng	20
17.30	Tepung beras	50
	Gula lempeng	20

Nilai gizi :	Energi	1220 kal
	Protein	17.83 gr
	Lemak	9.75 gr
	Karbohidrat	79.06 gr

- H2 : Bubur Sumsum

Tabel 5.8. Pembagian Bubur Sumsum

Jam	**Makanan**	**Berat (gr)**
06.00	Tepung beras	50
	Gula pasir	20
09.30	Snack	1 ptg
11.30	Tepung beras	50
	Gula pasir	20
17.30	Tepung beras	50
	Gula pasir	20

Nilai gizi :	Energi	1300kal
	Protein	20.80 gr

	Lemak	24.75 gr
	Karbohidrat	90.46 gr

3.Makanan Cair

- Diberikan kepada pasien sebelum dan sesudah operasi tertentu, keadaan mual dan muntah, prekoma, anorexia, kelumpuhan otot menelan, sesudah operasi mulut, tenggorokkan dan saluran pencernaan.
- Makanan cair atau makanan lewat pipa 1200 kalori, diberikan 6 kali dalam 1 hari, dimulai pada pukul 06.00 wib sampai dengan pukul 21.00 wib, dengan menggunakan formula komersial.
- Standar Pemberian

Tabel 5.9. Standar Pemberian Makanan Cair

Jadwal	Menu	Volume	Takaran/Saji			
			Entrasol	Peptisol	Diabetasol	Neprisol
06.00	E1	200	4	4	4	4
09.00	E2	200	4	4	4	4
12.00	E3	200	4	4	4	4
15.00	E4	200	4	4	4	4
18.00	E5	200	4	4	4	4
21.00	E6	200	4	4	4	4
Bila ekstra jus buah :						
09.00	E2	200	Buah 200 gr + gula pasir 30 gr/gula diet 1 sachet			
12.00	E3	200	4 ½	4 ½	4 ½	4 ½

Nilai gizi	Energi	1200 kal	1500 kal	1700 kal
	Protein	59 gr	71 gr	75 gr
	Lemak	35 gr	48 gr	48 gr
	Karbohidrat	173 gr	206 gr	

4.Diet Rendah Garam

- Diberikan kepada penderita dengan oedema atau hipertensi.

Tabel 5.10. Bahan Makanan Untuk Diet Rendah Garam

Gol. BM	Boleh Diberikan	Tidak Boleh Diberikan
Sumber KH	Beras, kentang, hunkwee, makaroni, mie, bihun.	Roti, biskuit dan kue-kue yang dimasak dengan garam dapur dan atau soda.

Sumber ProteinHewani	Daging, ayam, ikan, telur dimasak dengan sedikit garam.	Jerohan, udang, kerang, kepiting, cumi, lidah, keju makanan yang diawetkan.
Sumber Protein Nabati	Tahu, tempe dan kacang-kacangan dimasak dengan sedikit garam.	Tahu, tempe dan kacang-kacangan yang diawetkan.
Sayuran	Semua sayuran segar, dimasak dengan sedikit garam.	Sayuran yang diawetkan.
Buah-buahan	Semua buah segar	Buah yang diawetkan
Lemak	Minyak jagung, minyak biasa untuk menumis bumbu.	Santan, minyak kelapa, mentega, minyak untuk menggoreng.

5. Diet Diabetes Mellitus

- Diberikan kepada penderita yang memiliki kadar glukos yang tinggi dalam darah.

Tabel 5.11. Bahan Makanan Untuk Diet Diabetes Mellitus

Gol.BM	Dianjurkan	Tidak Dianjurkan
Sumber KH	Beras, ubi, singkong, kentang, roti tawar, tepung terigu, sagu, dan tepung singkong.	Sumber karbohidrat tinggi natrium, seperti cake, biscuit, dan krekes.
Sumber Protein Hewani	Daging tidak berlemak, ayam tanpa kulit, ikan, telur, susu dan hasil olahannya.	Daging dan ikan yang diawetkan, seperti ikan asing, dendeng, sarden dan *corned beef*.
Sumber Protein Nabati	Tempe, tahu, kacang hijau, kacang merah, kacang tanah, kacang kedela	-
Sayuran	Sayur tinggi serat: kangkung, daun kacang, oyong, ketimun, tomat, labu air, lobak, selada, seledri, wortel, terong.	Tinggi kalium, seperti bayam, bit, buncis, kembang kol, kol, labu walu, rebung, sawi, tauge, daun papaya, daun singkong, kluwih.
Buah-buahan	Rendah kalium, seperti jambu, kedondong, mangga, markisa, melon, nangka, pir sawo, salak.	Tinggi kalium, seperti anggur, arbei, belimbing, duku, jambu biji, jeruk, papaya, dan pisang.

Minuman	-	Minuman yang mengandung alkohol, susu kental manis, soft drink, es krim, yoghurt, susu, gula
Lainnya	-	Gula pasir, gula merah, gula batu, madu, Makanan/ minuman yang manis: cake, kue-kue manis, dodol, tarcis, sirup, selai manis, coklat, permen, tape, mayonnaise

6. Diet Rendah Lemak

- Diberikan untuk penderita yang memiliki kadar kolesterol tinggi, TBC,

Tabel 5.12. Bahan Makanan Untuk Rendah Lemak

Gol.BM	Dianjurkan	Tidak Dianjurkan
Sumber KH	Beras terutama beras tumbuk/beras merah, pasta, macaroni, roti tinggi serat (whole wheat bread), sereal, ubi, kentang, kue buatan sendiri dengan menggunakan sedikit minyak/lemak tidak jenuh.	Produk makanan jadi, speerti *pie*, *cake*, *croissant*, *pastries*, biskuit, krekes berlemak, dan kue-kue berlemak lain.
Sumber Protein Hewani	Ikan unggas tanpa kulit, daging kurus, putih telur, susu skim, yoghurt rendah lemak, dan keju rendah lemak.	Daging gemuk, daging kambing, daging babi, jeroan, otak, sosis, sarden, kuning telur, susu *whole*, susukental manis, krim, keju, es krim.
Sumber Protein Nabati	Tempe, tahu, dan kacang-kacangan.	Dimasak dengan santan dan digoreng dengan minyak jenuh, seperti kelapa dan kelapa sawit.
Sayuran	Semua sayur dalam bentuk segar, direbus, dikukus, disetup, ditumis menggunakan minyak jagung, dimasak dengan santan encer.	Sayuran yang dimasak dengan mentega, minyak kelapa atau minyak kelapa sawit dan santan kental.
Buah-buahan	Semua buah dalam keadaan segar atau bentuk jus.	Buah yang diawetkan dengan gula, seperti buah kaleng dan buahkering.

Sumber Lemak	Minyak jagung, kedelai, kacang tanah, bunga matahari, dan wijen; margarine tanpa garam yang dibuat dari minyak tidak jenuh ganda;mayones dan salad dressing tanpa garam yang dibuat dari minyak tidak jenuh ganda.	Minyak kelapa dan minyak kelapa sawit; mentega, margarine, santan, krim, mayones dan dressing yang dibuat dengan kuning telur.

7. Diet Rendah Purin

- Diberikan untuk penderita dengan kadar asam urat tinggi dalam darah

Tabel 5.13. Pengelompokkan Bahan Makanan Menurut Kadar Purin dan Anjuran Makan

Kelompok 1	**Kandungan purin tinggi (100-1000 mg purin/ 100 g bahan makanan) sebaiknya dihindari :** Otak, hati, jantung, ginjal, jeroan, ekstrak daging/kaldu, *bouillon*, bebek, ikan sarden, makarel, remis, kerang.
Kelompok 2	**Kandungan purin sedang (9-100 mg purin/ 100 g bahan makanan) dibatasi :** Maksimal (50-76g (1 – 1 ½ ptg)) daging, ikan atau unggas, atau 1 mangkok (100 g) sayuran sehari. Daging sapi dan ikan (kecuali yang terdapat dalam kelompok 1) ayam, udang; kacang kering dan hasil olahannya seperti tahu, tempe; asparagus, bayam, daun singkong, kangkung, daun dan biji melinjo).
Kelompok 3	**Kandungan purin rendah (dapat diabaiakan), dapat dimakan :** Nasi, ubi, singkong, jantung, roti, mie, bihun, tepung beras, cake, kue kering, pudding, susu, keju, telur; lemak dan minya; gula; sayuran dan buah-buahan (kecuali sayuran dalam kelompok 2)

8. Diet Rendah Protein

- Diberikan kepada penderita dengan penyakit ginjal

Tabel 5.14. Pengelompokkan Bahan Makanan Untuk

Gol.BM	Dianjurkan	Dibatasi
Sumber KH	Sumber karbohidrat sederhana : gula, selai, sirup, permen, madu untuk menambah energy, agar-agar, jelly.	Sumber karbohidrat kompleks: nasi, jagung, kentang, macaroni atau pasta, havermout, ubi/talas.

Sumber Protein Hewani	-	Daging kambing, ayam, ikan, hati, keju, udang, telur.
Sumber Protein Nabati	-	Tahu, tempe, oncom, kacang tanah, kacang merah, kacang tolo, kacang hijau, kacang kedelai.
Sayuran	Semua sayuran kecuali pasien dengan hiperkalemia.	Sayuran tinggi kalium seperti peterseli, buncis, bayam, daun papaya, daun singkong, labu waluh, dan lian-lain apabila pasien mengalami hiperkalemia.
Buah-buahan	Semua buah-buahan kecuali untuk pasien dengan hiperkalemia.	Buah-buahan tinggi kalium seperti apel, alpukat, jeruk, pisang, papaya, dll apabila pasien dengan hiperkalemia.
Sumber Lemak	Minyak jagung, minyak kacang tanah, minyak kelapa, minyak kedelai, dan margarine rendah garam.	Minyak kelapa sawit, santan kental, mentega, dan lemak hewan.

BAB VII
LOGISTIK

A. Pengertian

Manajemen pelayanan logistik dan pergudangan Unit Gizi merupakan penyelenggaraan pengurusan bahan makanan dan barang untuk memenuhi kebutuhan pelayanan gizi di rumah sakit secara teratur dalam kurun waktu tertentu secara cermat dan tepat dengan biaya seefisien mungkin.

B. Tujuan

1. Tujuan operasional yaitu tersedianya barang atau material dalam jumlah yang tepat dan kualitas yang baik pada waktu yang dibutuhkan.
2. Tujuan keuangan yaitu agar tujuan operasional di atas tercapai, dengan biaya yang rendah.
3. Tujuan keutuhan yaitu agar persediaan tidak terganggu oleh gangguan yang menyebabkan hilang atau kurang, rusak, pemborosan, penggunaan tanpa hak sehingga dapat mempengaruhi pembukuan atau sistem akuntansi.

C. Syarat Manajemen Logistik

1. Sirkulasi pengeluaran bahan makanan atau barang berdasar metode FIFO (First In First Out).
2. Fasilitas penyimpanan terstandar (bersih dan suhu sesuai).
3. Stok bahan makanan atau barang tersedia dalam kurun waktu tertentu
4. Menjaga kualitas bahan makanan tetap terjamin.
5. Adanya sistem pencatatan.

D. Kegiatan Logistik Unit Gizi

1. Perencanaan kebutuhan bahan makanan

.Pengertian :serangkaian kegiatan menetapkan macam,jumlah dan mutu ba-
han makanan yang diperlukan dalam kurun waktu tertentu,dalam rangka -
mempersiapakan penyelenggaraan makan rumah sakit daerah Kalabahi.

a.Tujuan:

Tersediahnya taksiran macam dan jumlah bahan makanan dengan spesifi-Kasih yang ditetapkan ,dalam kurun waktu yang dibutuhkan pasien.

b..Langka-langka perhitungan kebutuhan bahan makanan.menyusun bahan makan yang di perlukan yaitu bahan makanan segar dan bahan makanan kering.

* Menghitung kebutuhan bahan makanan satu persatu dengan cara

- menetapkan jumlah pasien rata-rata yang dilayani.
- menghitung macam dan kebutuhan makan dalam satu siklus Menu (7 hari)

2. Pengadaan Bahan makanan.

Kegitan pengadaan bahan makanan meliputi penetapan spesifikasi bahan Makanan,perhitungan harga makanan,pemesanan dan pembelian bahan Makanan dan melakukan survey pasar.

a. Spesifikasi Bahan makanan adalah standar bahan makanan yang dite tapkan oleh unit sesuai dengan ukuran, bentuk,penampilan dan kwalitas bahan makanan.
b. spesifikasi penampilan . adalah bahan makanan haruslah sesederhana,lengkap dan jelas secara garis besar. Yaitu nama,prodak,ukuran,kemasan.kwalitas,umur,warna bahan makanan,masa kadaluarsa.
c. Survey pasar adalah kegiatan untuk mencari informasi mengenai harga Bahan makanan yang ada di pasaran ,sesusi dengan spesifikasi yang-dibutuhkan sebagai dasar perencanaan anggaran bahan makanan.Dari survey tersebut akan diperoleh perkiraan harga bahan makanan yang

meliputi harga terendah ,harga tertinggi ,harga tertimbang dan harga -perkiraan rumah sakit.

Pemesanan bahan makanan

Rangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan bahan makanan yang disesuaikan dengan spesifikasi yang sesuai standar RS Daerah Kalabahi dalam surat pemesanan belanja.

a. Bahan Kering
    - Penanggung jawab logistik melihat persediaan bahan makanan dan minuman kering secara fisik dan mencocokkan dengan kartu stock, apabila persediaan sudah menipis maka bagian logistik langsung melakukan pemesanan bahan makanan kering kepada supplier.
    - Setelah pesanan datang, maka petugas logistik memeriksa bahan yang datang disesuaikan dengan nota pesanan, bahan yang tidak sesuai spesifikasi akan dikembalikan, dan bahan yang tidak datang akan dicoret dari nota.
    - Nota yang diterima dari supplier diserahkan kepada kepala unit untuk diperiksa dan dibayarkan kepada supplier.
b. Bahan basah

- PJ shift juru masak membuat pesanan kebutuhan bahan makanan untuk esok hari (menu siang, sore dan pagi hari berikutnya).
- Pramumasak shift pagi yang belanja kepasar untuk membeli bahan makanan basah untuk kebutuhan makanan hari berikutnya.

4. Penerimaan Bahan Makanan

Rangkaian kegiatan meneliti, memeriksa, mencatat dan melaporkan bahan makanan yang diperiksa sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan oleh Rumah Sakit Daerah Kalabahi dengan supplier yang bersangkutan.

Adapun prinsip dalam penerimaan bahan makanan di Rumah Sakit Daerah Kalabahi :

a) Jumlah

Bahan makanan yang diterima harus sama dengan jumlah bahan makanan yang tertulis dalam surat pemesanan.

b) Mutu

Bahan makanan yang diterima harus sesuai dengan spesifikasi bahan makanan di Rumah Sakit Daerah Kalabahi.

c) Harga

Bahan makanan yang tercantum pada surat pemesanan harus sama dengan harga bahan makanan yang tercantum pada penawaran bahan makanan sebelumnya.Apabila terjadi ketidaksesuaian baik dari segi jumlah, mutu maupun harga bahan makanan pihak Rumah Sakit Daerah Kalabahi berhak untuk mengembalikan bahan makanan tersebut untuk ditukar oleh supplier sesuai dengan standar dari Rumah Sakit Daerah Kalabahi.Setiap ketidaksesuaian saat penerimaan bahan makanan, maka dicatat dalam buku komplain kepada supplier, sebagai evaluasi terhadap supplier setiap satu bulan sekali. Cara penerimaan yang ada di Rumah Sakit Daerah Kalabahi yaitu secara konvensional yang memperhitungkan baik kualitas maupun kuantitas.

Prosedur dalam penerimaan bahan makanan meliputi :

1) Supplier mengirimkan bahan makanan sesuai dengan bon pemesanan yang diberikan oleh pihak unit gizi.

2) Penanggung jawab logistik gizi menerima dan memeriksa jumlah atau jenis bahan makanan yang diterimanya dengan nota 2 rangkap dari supplier.
3) Penanggung jawab logistik memeriksa pembebanan harga sesuai dengan harga yang diterima.
4) Penanggung jawab logistik mencatat semua bahan makanan yang diterima dalam kartu stok kolom masuk, dan menyimpan sesuai dengan tata laksana penyimpanan bahan makanan kering. Sedangkan untuk bahan makanan basah, langsung didistribusikan ke bagian persiapan (bumbu, lauk dan sayur)untuk pengolahan.

5. Penyimpanan Bahan Makanan

Suatu kegiatan yang menyangkut pemasukan bahan makanan, penyimpanan bahan makanan, serta penyaluran sesuai dengan permintaan untuk persiapan pemasakan bahan makanan.

Adapun prinsip dalam penyimpanan bahan makanan :

2. Tempat yang tepat
3. Waktu yang tepat
4. Mutu yang sesuai dengan standar rumah sakit
5. Jumlah sesuai dengan surat pemesanan yang diberikan pihak rumah sakit.
6. Harga sesuai dengan harga yang telah disepakati baik pihak rumah sakit ataupun supplier.

Prosedur penyimpanan bahan makanan Rumah Sakit Daerah Kalabahi meliputi :

a) Penyimpanan bahan makanan kering

Penanggung jawab logistik menata bahan makanan kering sesuai dengan spesifikasinya dan mencatat pada kartu stock baik setiap bahan datang maupun bahan makanan yang keluar sesuai dengan kebutuhan selama pengolahan di unit gizi, selain itu sesuai dengan permintaan dari instalasi terkait. Penyimpanan bahan makanan kering di Rumah Sakit Daerah Kalabahi dilakukan dengan metode *First In First Out* (FIFO), sehingga stock bahan yang lebih lama dapat digunakan terlebih dahulu. Ruang penyimpanan kering terdapat ventilasi sebagai sirkulasi udara agar ruangan tidak terlalu lembab atau pengap. Ruang penyimpanan kering juga dilengkapi dengan adanya timbangan untuk membantu jalannya permintaan

bahan kering. Penyimpanan bahan makanan kering harus disesuaikan dengan suhu 23 – 27ºC.

Bahan makann kering tidak menempel dilantai,dinding atau langit -langit

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Jarak bahan makanan dengan lantai : 15 cm
- Jarak antara mkanan dengan dinding :5 cm
- Jarak bahan makan dengan langit-langit : 60 cm.

b) Penyimpanan bahan makanan basah

Penanggung jawab logistik langsung mendistribusikan bahan makanan kepada bagian persiapan, baik bumbu, lauk maupun sayur. Bahan makanan yang digunakan untuk pengolahan besoknya, dibersihkan dan dicuci kemudian dibungkus menggunakan plastik putih dan dimasukkan ke dalam lemari es untuk menjaga kualitas bahan makanan.

Karyawan di Unit Gizi membersihkan lemari es setiap satu kali dalam seminggu yang sudah disesuaikan dengan jadwal dinas untuk menghindari pengerasan es. Penyimpanan bahan makanan basah menggunakan metode *Just In Time* sehingga bahan makanan langsung digunakan untuk proses selanjutnya, adapun menggunakan metode FIFO dilakukan pada bahan makanan beku.

Penanggung jawab logistik mengecek suhu pada refrigerator, chiller dan freezer dengan mengisi form checklist suhu dalam waktu intensitas minimal 1 x 24 jam. Suhu penyimpanan untuk refrigerator yang dianjurkan yaitu 0ºC, sedangkan untuk suhu freezer yaitu -20ºC - -5ºC dan untuk suhu chiller yaitu -2 – 12ºC.

6.Pemeliharaan dan Perawatan

Suatu kegiatan untuk menjaga kualitas bahan makanan baik kering maupun basah untuk menghasilkan makanan yang baik untuk dikonsumsi. Prinsip dalam pemeliharaan dan perawatan adalah adanya pengawasan ruangan dalam penyimpanan baik makanan kering maupun makanan basah misalnya suhu lemari es untuk penyimpanan bahan makanan basah. Penanggung jawab logistik menjaga kebersihan ruangan penyimpanan untuk menghindari bahaya binatang (kecoa, tikus, dan lain-lain) agar bahan makanan dapat terjaga dengan baik.

7.Pengeluaran dan penyerahan bahan makanan

Suatu kegiatan yang mengawasi persediaan bahan makanan kering maupun basah sehingga tidak terjadi penumpukkan bahan makanan yang terlalu banyak, dan mengevaluasi bahan makanan yang dibutuhkan oleh unit gizi. Penanggung jawab logistik melakukan evaluasi pengeluaran bahan makanan dan kebutuhan selama proses produksi untuk perencanaan selanjutnya.

Cara penyimpanan bahan makanan kering (gudang kering):

a. Bahan makanan ditempatkan secara teratur menurut golongan bahan makanan.
b. Menggunakan bahan yang diterima terlebih dahulu (FIFO), untuk mengetahui bahan makanan yang diterima diberi tanda tanggal penerimaan.
c. Pemasukan dan pengeluaran bahan makanan ditulis ke dalam kartu stock, dan dicatat di dalam pembukuan komputer.
d. Pengambilan bahan makanan kering dilakukan setiap hari.
e. Semua bahan makanan ditempatkan di atas rak bertingkat yang cukup kuat dan tidak menempel pada dinding.
f. Pintu gudang selalu terkunci pada saat tidak ada kegiatan serta dibuka pada waktu-waktu yang ditentukan (saat mengeluarkan dan memasukkan barang). Suhu ruang penyimpanan kering berkisar antara 19 - 21ºC.
g. Pembersihan ruangan secara periodik, 2 kali seminggu.

Cara penyimpanan bahan makanan segar :

a. Bahan makanan segar disimpan di dalam lemari pendingin, sesuai dengan masing-masing jenisnya.
b. Untuk daging, ayam, ikan dan udang, disimpan ke dalam freezer dan terbungkus rapi.
c. Untuk sayuran disimpan di dalam lemari es.
d. Untuk buah disimpan di keranjang di suhu ruang, bila ada sisa baru disimpan ke dalam lemari es.

Tabel 6.1. Suhu dan Lama Penyimpanan Bahan Makanan Mentah/Segar

Bahan Makanan	Lama Waktu Penyimpanan		
	< 3 hari	≤ 1 minggu	≥ 1 minggu
Daging, ikan, udang dan	-5 - 0ºC	-10 - -5ºC	< -10ºC

hasil olahannya			
Telur, buah dan hasil olahannya	5 - 7ºC	-5 - 0ºC	< 5ºC
Sayur, buah dan minuman	10ºC	10ºC	10ºC
Tepung dan biji-bijian	25ºC	25ºC	25ºC

7.Penyaluran Bahan Makanan

Penyaluran bahan makanan adalah tata cara mendistribusikan bahan makanan berdasarkan permintaan harian.

Tujuan :Tersedianya bahan makanan siap pakai dengan kualitas dan kuantitas yang tepat sesuai dengan pesanan

Pra syarat :

a. Ada bon permintaan bahan makanan.
b. Tersedia kartu stock/buku catatan keluar masuknya bahan makanan.

E. Pengolahan Bahan Makanan

Suatu kegiatan mengubah (memasak) bahan makanan mentah menjadi makanan yang siap dimakan, berkualitas dan aman untuk dikonsumsi.

Tujuan :

- Mengurangi resiko kehilangan zat gizi bahan makanan.
- Meningkatkan nilai cerna.
- Meningkatkan dan mempertahankan warna, rasa, keempukan dan penampilan makanan.

F. Pemilihan Bahan Makanan

Serangkaian kegiatan yang meliputi pemilihan kualitas dan kuantitas bahan makanan yang sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan.

Tujuan : Dipilih bahan makanan sesuai dengan daftar pesanan, waktu pesanan dan spesifikasi yang ditetapkan.

G. Persiapan Makanan

Persiapan makanan meliputi :

a. Persiapan Bahan Makanan Pokok
b. Persiapan Buah
c. Persiapan Bumbu
d. Persiapan Lauk

e. Persiapan Sayur
f. Pembuatan Susu
g. Pembuatan Sonde dengan Formula Komersil
h. Pembuatan Sonde dengan Formula Rumah Sakit Untuk Pasien Gizi Buruk
i. Persiapan Snack

BAB VIII
KESELAMATAN PASIEN

A. Pengertian

Keselamatan pasien adalah suatu sistem di mana rumah sakit membuat asuhan pasien lebih aman. Hal ini termasuk pengkajian resiko, identifikasi dan pengelolaan hal yang berhubungan dengan resiko pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden dan tindak lanjutnya serta implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya resiko.

Sedangkan insiden keselamatan pasien adalah setiap kejadian atau situasi yang dapat mengakibatkan atau berpotensi menimbulkan harm (penyakit, cidera, cacat, kematian dan lain-lain) yang tidak seharusnya terjadi.

B. Tujuan

Tujuan sistem ini adalah mencegah terjadinya cidera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang tidak seharusnya diambil. Selain itu sistem keselamatan pasien ini mempunyai tujuan agar tercipta budaya keselamatan pasien di rumah sakit, meningkatnya akuntabilitas rumah sakit terhadap pasien dan masyarakat, menurunnya kejadian tidak diharapkan di rumah sakit, dan terlaksananya program-program pencegahan sehingga tidak terjadi pengulangan kejadian tidak diharapkan.

C. Tata laksana keselamatan pasien

Dalam melaksanakan keselamatan pasien terdapat tujuh langkah menuju keselamatan pasien rumah sakit. Adapun tujuh langkah tersebut adalah :

a. Membangun kesadaran akan nilai keselamatan pasien. Menciptakan kepemimpinan dan budaya yang terbuka dan adil.
b. Memimpin dan mendukung karyawan. Membangun komitmen dan fokus yang kuat dan jelas tentang keselamatan pasien.
c. Mengintegrasikan aktivitas pengelolaan resiko. Mengembangkan sistem dan proses pengelolaan resiko, serta melakukan identifikasi dan pengkajian hal potensial bermasalah.

d. Mengembangkan sistem pelaporan. Memastikan karyawan agar dengan mudah dapat melaporkan kejadian/insiden, serta rumah sakit mengatur pelaporan kepada Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit.
e. Melibatkan dan berkomunikasi dengan pasien. Mengembangkan cara-cara komunikasi yang terbuka dengan pasien.
f. Belajar dan berbagi pengalaman tentang keselamatan pasien. Mendorong karyawan untuk melakukan analisis akar masalah untuk belajar bagaimana dan mengapa kejadian itu timbul.
g. Mencegah cedera melalui implementasi sistem keselamatan pasien. Menggunakan informasi yang ada tentang kejadian atau masalah untuk melakukan perubahan pada sistem pelayanan.

Dalam melaksanakan keselamatan pasien standar keselamatan pasien harus diterapkan. Standar tersebut sebagai berikut :

a. Hak pasien
b. Mendidik pasien dan keluarga
c. Keselamatan pasien dan kesinambungan pelayanan
d. Penggunaan metode-metode peningkatan kinerja untuk melakukan evaluasi dan program peningkatan keselamatan pasien.
e. Peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan pasien.
f. Mendidik karyawan tentang keselamatan pasien.
g. Komunikasi yang merupakan kunci bagi karyawan untuk mencapai keselamatan pasien.

Langkah-langkah penerapan keselamatan pasien rumah sakit.

a. Menetapkan instalasi kerja yang bertanggung jawab mengelola program keselamatan pasien rumah sakit.
b. Menyusun program keselamatan pasien rumah sakit jangka pendek 1 – 2 th.
c. Mensosialisasikan konsep dan program keselamatan pasien rumah sakit.
d. Mengadakan pelatihan keselamatan pasien rumah sakit bagi jajaran manajemen dan karyawan.
e. Menetapkan sistem pelaporan insiden (peristiwa keselamatan pasien).
f. Menerapkan tujuh langkah menuju keselamatan pasien rumah sakit seperti tersebut di atas.

g. Menerapkan standar keselamatan pasien rumah sakit (seperti tersebut di atas) dan melakukan self assesment dengan instrument akreditasi pelayanan keselamatan pasien rumah sakit.
h. Program khusus keselamatan pasien rumah sakit.
i. Mengevaluasi secara periodik pelaksanaan program keselamatan pasien rumah sakit dan kejadian tidak diharapkan.

Sasaran keselamatan pasien di Unit Gizi Rumah Sakit Daerah Kalabahi

a. Ketepatan identifikasi pasien

   Ketepatan identifikasi pasien adalah ketepatan penentuan identitas pasien sejak awal pasien masuk sampai dengan pasien keluar terhadap semua pelayanan yang diterima oleh pasien.

b. Peningkatan komunikasi yang efektif

   Peningkatan komunikasi yang efektif adalah komunikasi lisan yang menggunakan prosedur “SBAR” : Write, Read and Repeat Back (reconfirm).

BAB IX
KESELAMATAN KERJA

Undang-undang nomor 36 tahun 2009 pasal 164 ayat 1 menyatakan bahwa upaya kesehatan kerja ditujukan untuk melindungi pekerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh pekerjaan. Rumah sakit adalah tempat kerja yang termasuk dalam kategori tersebut di atas, berarti wajib menerapkan upaya kesehatan dan keselamatan kerja. Program kesehatan dan keselamatan kerja di tim pendidikan pasien dan keluarga bertujuan melindungi karyawan dari kemungkinan terjadinya kecelakaan di dalam dan di luar rumah sakit.

Dalam undang-undang dasar 1945 pasal 27 ayat 2 (dua) disebutkan bahwa "setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Dalam hal ini yang dimaksud pekerjaan adalah pekerjaan yang bersifat manusiawi, yang memungkinkan pekerja berada dalam kondisi sehat dan selamat, bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja, sehingga dapat hidup layak sesuai dengan martabat manusia.

Kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 merupakan bagian integral dari perlindungan terhadap pekerja dalam hal ini unit gizi dan perlindungan terhadap rumah sakit. Pegawai adalah bagian integral dari rumah sakit. Jaminan keselamatan dan kesehatan kerja akan meningkatkan produktivitas pegawai dan meningkatkan produktivitas rumah sakit. Undang-undang no 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja dimaksudkan untuk menjamin :

a. Agar pegawai dan setiap orang yang berada di tempat kerja selalu berada dalam keadaan sehat dan selamat.
b. Agar faktor-faktor produksi dapat dipakai dan digunakan secara tepat dan efisien.
c. Agar proses produksi dapat berjalan lancar tanpa hambatan.

Faktor-faktor yang menimbulkan kecelakaan dan penyakit akibat kerja dapatdigolongkan pada tiga kelompok, yaitu :

a. Kondisi dan lingkungan kerja
b. Kesadaran dan kualitas pekerja
c. Peranan dan kualitas manajemen

Dalam kaitannya dengan kondisi dan lingkungan kerja, kecelakaan dan penyakit akibat kerja dapat terjadi bila :

- Peralatan tidak memenuhi standar kualitas atau bila sudah aus.
- Alat-alat produksi tidak disusun secara teratur menurut tahapan proses produksi.

- Ruang kerja terlalu sempit, ventilasi udara kurang memadai, ruangan terlalu panas atau terlalu dingin.
- Tidak tersedia alat-alat pengaman.
- Kurang memperhatikan persyaratan penanggulangan bahaya kebakaran dan lain-lain.

1. Perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja dan petugas kesehatan
    - Petugas kesehatan yang merawat pasien menular harus mendapatkan pelatihan mengenai cara penularan dan penyebaran penyakit, tindakan pencegahan dan pengendalian infeksi yang sesuai dengan protokol jika terpajan.
    - Petugas yang tidak terlibat langsung dengan pasien harus diberikan penjelasan umum mengenai penyakit tersebut.
    - Petugas kesehatan yang kontak dengan pasien penyakit menular melalui udara harus menjaga fungsi saluran pernafasan (tidak merokok, tidak minum dingin) dengan baik dan menjaga kebersihan tangan.

2. Petunjuk pencegahan infeksi untuk petugas kesehatan.
    - Untuk mencegah transmisi penyakit menular dalam tatanan pelayanan kesehatan, petugas harus menggunakan APD yang sesuai untuk kewaspadaan standar dan kewaspadaan isolasi (berdasarkan penularan secara kontak, droplet atau udara) sesuai dengan penyebaran penyakit.
    - Semua petugas kesehatan harus mendapatkan pelatihan tentang gejala penyakit menular yang sedang dihadapi.
    - Semua petugas kesehatan dengan penyakit seperti flu harus dievaluasi untuk memastikan agen penyebab. Dan ditentukan apakah perlu dipindah tugaskan dari kontak langsung dengan pasien, terutama mereka yang bertugas di instalasi perawatan intensif, ruang rawat anak, ruang bayi.
    - Semua petugas di unit gizi harus menggunakan apron, penutup kepala dan pelindung kaki (sandal/sepatu boot), sebelum masuk ke dapur. Selain petugas unit gizi yang masuk ke dapur harus mengenakan APD tersebut hal ini bertujuan untuk mengurangi kontaminasi yang dapat mencemari makanan, sehingga makanan aman dikonsumsi oleh pasien. Petugas dalam mengolah makanan harus menggunakan masker atau tidak boleh berbicara dengan petugas pengolah yang lain.

3. Prinsip keselamatan kerja karyawan dalam proses penyelenggaraan makanan.
   a) Pengendalian teknis mencakup
      - Letak, bentuk dan konstruksi alat sesuai dengan kegiatan dan memenuhi syarat yang telah ditentukan.
      - Ruang dapur cukup luas, denah sesuai dengan arus kerja dan dapur dibuat dari bahan-bahan atau konstruksi yang memenuhi syarat.
      - Perlengkapan alat kecil yang cukup disertai tempat penyimpanan yang praktis.
      - Penerapan dan ventilasi yang cukup memenuhi syarat.
      - Tersedianya ruang istirahat untuk karyawan.
   b) Adanya pengawasan kerja yang dilakukan oleh penanggung jawab dan terciptanya kebiasaan kerja yang baik oleh karyawan.
   c) Pekerjaan yang ditugaskan hendaknya sesuai dengan kemampuan kerja dari karyawan.
   d) Volume kerja yang dibebankan disesuaikan dengan jam kerja yang telah ditetapkan.
   e) Maintenance (perawatan) alat dilakukan secara rutin oleh petugas instalasi pemeliharaan sarana sesuai jadwal.
   f) Adanya pendidikan mengenai keselamatan kerja bagi karyawan.
   g) Adanya fasilitas atau peralatan pelindung dan peralatan pertolongan pertama yang cukup.

4. Prosedur keselamatan kerja
   a) Ruang penerimaan dan penyimpanan bahan makanan.
      Keamanan kerja di ruang ini meliputi :
      - Menggunakan alat pembuka peti/bungkus bahan makanan menurut cara yang tepat.
      - Barang yang berat selalu ditempatkan di bagian bawah dan angkatlah dengan alat pengangkut yang tersedia untuk barang tersebut.
      - Pergunakan tutup kotak/tutup panci yang sesuai dan hindari tumpahan bahan.
      - Tidak diperkenankan merokok di ruang penerimaan dan penyimpanan bahan makanan.
      - Lampu harus dimatikan bila tidak dipergunakan/diperlukan.
      - Tidak mengangkat barang berat, bila tidak sesuai dengan kemampuan.

- Tidak mengangkat barang dalam jumlah yang besar, yang dapat membahayakan badan dan kualitas barang.
- Membersihkan bahan yang tumpah atau keadaan licin di ruang penerimaan dan penyimpanan.

b) Di Ruang Persiapan dan Pengolahan Makanan

- Menggunakan peralatan yang sesuai dengan cara yang baik.
- Tidak menggaruk, batuk, selama mengerjakan/mengolah bahan makanan.
- Menggunakan berbagai alat yang tersedia sesuai dengan petunjuk.
- Bersihkan mesin menurut petunjuk dan matikan mesin sebelumnya.
- Menggunakan serbet sesuai dengan macam dan peralatan yang akan dibersihkan.
- Berhati-hati bila membuka dan menutup, menyalakan atau mematikan mesin, lampu, gas/listrik dan lain-lain.
- Meneliti dulu semua peralatan sebelum digunakan.
- Pada saat selesai menggunakannya, teliti kembali apakah semua alat sudah dimatikan mesinnya.
- Mengisi panci-panci menurut ukuran semestinya, dan jangan melebihi porsi yang ditetapkan.
- Tidak memuat kereta makan melebihi kapasitasnyal.
- Meletakkan alat menurut tempatnya dan diatur dengan rapi.

c) Di Ruang Pembagian Makanan di Unit Pelayanan Gizi

- Tidak mengisi panci/piring terlalu penuh.
- Tidak mengisi kereta makan melebihi kapasitas kereta makan.
- Bila membawa air panas, tutuplah dengan rapat atau tidak mengisi tempat tersebut sampai penuh.

d) Alat Pelindung Kerja

- Baju kerja, celemek dan topi terbuat dari bahan yang tidak panas, tidak licin dan enak dipakai, sehingga tidak mengganggu gerak pegawai sewaktu kerja.
- Menggunakan sandal yang tidak licin bila berada di lingkungan dapur (jangan menggunakan sepatu yang berhak tinggi).
- Menggunakan cempal/serbet pada tempatnya.

- Tersedia alat sanitasi yang sesuai, misalnya air dalam keadaan bersih dan jumlah yang cukup, sabun, alat pengering, dsb.
- Tersedia alat pemadam kebakaran yang berfungsi baik di tempat yang mudah dijangkau.
- Tersedia alat/obat P3K.

BAB IX
HIGIENE DAN SANITASI MAKANAN

A. Pengertin Umum Higiene dan Sanitasi

Pada hakekatnya higiene dan sanitasi mempunyai pengertian dan tujuan yang hampir sama yaitu mencapai kesehatan yang prima. Hygiene adalahusaha kesehatan preventif yang menitik beratkan kegiatannya kepada usaha kesehatan individu. Sedangkan sanitasi adalah usaha kesehatan lingkungan lebih banyak memperhatikan masalah kebersihan untuk mencapai kesehatan.

Sanitasi makanan merupakan salah satu upaya pencegahan yang menitik beratkan apada kegiatan dan tindakan yang perlu untuk membebaskan makanan dan minuman dari segala bahaya yang mengganggu atau merusak kesehatan mulai dari sebelum makanan doproduksi, selama proses pengolaham, penyiapan, pengangkutan, penjualan, sampai saat makanan dan minuman tersebut siap untuk dikonsumsikan kepada konsumen.

Persyaratan hygiene dan sanitasi makanan dan minuman harus sesuai dengan peraturan yang berlaku, mengacu kepada keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1204/MENKES/KEP/X/2004 tentang persyaratan kesehatan lingkungan rumah sakit.

1. Tujuan

Kegiatan penyehatan makanan dan minuman di Rumah Sakit ditujukn untuk :

a. Tersedianya makanan yang berkualitas baik dan aman bagi kesehatan konsumen.
b. Menurunnya kejadian risiko penularan penyakit atau gangguan kesehatan melalui makanan.
c. Terwujutnya perilaku kerja yang sehat dan benar dalam penanganan makanan.

Kegiatan penyehatan makanan dan minuman di Rumah Sakit, menekankan terwujutnya kebersihan dan keamanan makanan dalam alur perjalanan makanan sebelum dikonsumsi oleh manusia. Karena itu alur tersebut perlu di pahami agar memberi gambaran yang jelas dimana titik rawan dalam jalur yang dapat menimbulkan risiko bahaya.

Langkah langkah dalam mewujutkan hygiene dan sanitasi makanan

- Mempertahankan hasil produksi yang sesuai dengan hasil hidangan (panas/dingin)
- Makanan di persiapkan lebih awal.
- Memasak tepat waktu dan suhu.
- Penjamah makanan yang sehat mulai penerimaan hingga distribusi.
- Memantau suhu makanan sebelum di bagiakan.
- Memantau secara teratut bahan makanan mentah dan bumbu bumbu sebelum di masak.
- Panaskan kembali sisa makan menurut suhu yang tepat (74 ℃)
- Menghindari kontaminasi silang antara bahan makanan mentah, makanan masak melalui tangan atau alat makan dan alat dapur.
    - Bersikan semua permukaan alat/tempat setelah digunakan untuk mananan.

B.Hygiene Tenaga Penjamah Makanan

Kebersiahan diri dan kesehatan penjamah makanan merupakan kunci keberhasilan dalam pengolahan mananan yang aman dan sehat, karena penjamah makanan juga menjadi salah satu fektor yang dapat mencemari bahan pangan baik berupa cemaran fisik, kimia maupun biologis.

Upaya yang dapat dilakukan adalah penerapan prinsip prinsip personal hygiene.

1. Sumber cemaran dari tubuh manusia yaitu : tangan, rambut, mulut, hidung, telinga, organ pembuangan (dubur dan organ kemaluan). Penjamah makanan mandi secara teratur dengan sabun dan yang bersih. Menyikat gigi dengan pasta gigi,, berpakaian yang bersih, membiasakan diri selalu membertsihkan lubang hidung, lubang teling dan kuku secara rutin, kuku selalu pendek agar mudah di bersihkan, menjaga kebersuhan kulit dari bahan bahan kosmetik yang tidak perlu.
2. Sumber cemaran yang lain yaitu : luka terbuka/koreng, bisul, dan ketombe dari rambut. Luka teriris segera ditutup dengan plester tahan air, koreng , bisul tahan dini ditutup dengan plester tahan air. Rambut ditutup dengan penutup kepala yang bagian depan sehingga tidak terurai.
3. Sumber cemaran karena perilaku yaitu : tanganyang kotor, batuk, bersin atau percikan ludah, menuyisir rambut dekat makanan.

4. Sumber cemaran karena ketidaktahuan. Ketidaktahuan dapat terjadi karena pengetahuan yang rendah dan kesadarannya pun rendah. Hal tersebut menyebabkan terjadinya penyalahgunaan bahan makanan yang dapat menimbulkan bahaya seperti :
    - Pemakaian bahan palsu
    - Pemakaian bahan pangan rusak/rendah kualitas
    - Tidak bisa membedakan bahan panagan dan bukan bahan pangan
    - Tidak bisa membedakan jenis pewarna yang aman untuk bahan makanan.

C.Higene Peralatan dan Pengolahan makanan.

Peralatan dan pengolahan yang kotor dapat mencemari pangan,oleh –
karena itu peralatan harus di jaga agar selalu tetap bersih.Upaya –upaya untuk menghindari pencemaran pangan dari peralatan yang kotor,dilakukan hal hal-hal berikut.

*. Menggunakan peralatan yang mudah dibersihkan.Peralatan yang ter-
Buat dari stainless stell umumnya mudah di bersihkan.

* Bersihkan permukaan meja tempat pengolahan pangan dengan sabun-
Dengan bersih dan benar.

*.Bersihkan semua peralatan termasuk pisau,sendok panci ,piring dan –
Lain- lainya.

*Letakkan peralatan yang tidak terpakai menghadap ke bawah,bilas kem-
Bali peralatan sebelum dipakai memasak.

Pencucian yang benar akan memberikan hasil yang sehat dan amandengan-
Beberapa tahap pencucian:

a. Membuang sisa pengolahan
b. Merendam dalam air
c. Mencuci dengan deterjen
d. Membilas dengan air bersih.

BAB X
PENGENDALIAN MUTU

A. Bentuk-bentuk Pengawasan dan Pengendalian

1. Pencatatan dan pelaporan

a. Pencatatan dan Pelaporan Pengadaan Makanan
   - Bon pemesanan bahan makanan harian
   - Pencatatan bahan makanan yang diterima oleh bagian gudang pada hari itu.
   - Pencatatan sisa bahan makanan harian/bulanan, meliputi bahan makanan basah dan bahan makanan kering.

b. Pencatatan dan Pelaporan Tentang Penyelenggaraan Makanan
   - Buku operan harian.
   - Buku laporan kegiatan harian.

c. Pencatatan dan Pelaporan Tentang Perlengkapan Peralatan di Unit gizi.
   - Membuat inventaris peralatan di unit gizi.

d. Pencatatan dan pelaporan anggaran belanja bahan makanan.
   - Pencatatan tentang pemasukan dan pengeluaran bahan makanan harian.
   - Rekapitulasi tentang pemasukan dan pengeluaran bahan makanan.
   - Perhitungan harga rata-rata pemakaian bahan makanan per orang per hari dalam satu kali putaran menu.
   - Pencatatan tentang penggunaan bahan bakar per bulan.

e. Pencatatan dan Pelaporan Pelayanan Gizi di IRNA dan IRJ
   - Formulir asuhan gizi (disimpan di dalam status pasien).
   - Formulir permintaan makan pagi, siang dan sore.
   - Buku ekspedisi kegiatan konsultasi gizi (IRNA dan IRJ).

2. Pengawasan Standar Porsi

a. Untuk bahan makanan (padat) pengawasan porsi dilakukan dengan penimbangan.

b. Untuk bahan makanan yang cair atau setengah cair seperti susu dan bumbu dipakai gelas ukuran/litter matt, sendok ukuran atau alat ukur lain yang sudah distandarisasi atau bila perlu ditimbang.
c. Untuk pemotongan bentuk bahan makanan yang sesuai untuk jenis hidangan, dapat dipakai alat-alat pemotong atau dipotong menurut petunjuk.

3. Pengawasan Harga

a. Tetapkan kebijakan keuangan yang ingin dicapai
b. Buat format isian pelaksanaan pencatatan pelaporan yang baku untuk pengawasan.
    1) Pencatatan pemasukan, penerimaan bahan makanan, harian tiap putaran menu, bulanan, triwulan dan tahunan.
    2) Kalkulasi harga pemasukan bahan makanan, harga pemakaian bahan makanan untuk setiap putaran menu, bulanan, triwulan dan tahunan.
    3) Perhitungan stock bahan makanan.
    4) Biaya overhead.
    5) Biaya tenaga kerja.
c. Kalkulasi pemasukan dan pengeluaran bahan makanan berikut nilai rupiahnya.
d. Hitung biaya per porsi atau biaya per orang per hari.

4. Pengendalian Biaya

a. Tujuan Pengendalian Biaya
    1) Menganalisa biaya yang direncanakan dibandingkan dengan harga yang sesungguhnya digunakan untuk penyelenggaraan makanan.
    2) Menilai harga penawaran bahan makanan.
    3) Mencegah sisa bahan makanan yang tidak efisien.
    4) Menyediakan data untuk laporan penyelenggaraan institusi.
    5) Membandingkan dua atau lebih kegiatan pelaksanaan penyelenggaraan makanan.
b. Cara pengendalian biaya makan
    1) Kembangkan kebijakan keuangan bagi institusi. Hal ini tergantung pada tujuan dan bentuk kegiatan, target keuntungan dan prosentase dari makanan, tenaga dan biaya overhead lainhnya yang dapat dicapai.
    2) Kembangkan pengendalian secara rutin. Pengendalian kegiatan harus mencakup prosedur kerja karyawan dan pemeriksaan menyeluruh mulai dari

perencanaan menu, pembelian, penerimaan , penyimpanan, pengeluaran, produksi, distribusi serta penyajian/penjualan.

3) Pengendalian pada pos kegiatan. Hal ini berkaitan dengan laporan biaya makan, perhitungan hasil, dan mengambil tindakan perbaikan jika diperlukan.

c. Kendala dalam Pengendalian Biaya

1) Banyak menggunakan bahan makanan yang mudah rusak
2) Banyaknya volume kegiatan yang tidak dapat diperkirakan sehingga sulit membuat perkiraan jumlah makanan secara tepat yang harus disiapkan.
3) Tidak stabilnya kondisi pasar sehingga dapat mempengaruhi harga bahan makanan.
4) Banyaknya variasi makanan yang harus diproduksi.

d. Langkah-langkah Dalam Proses Pengendalian

Empat langkah dasar yang harus dilakukan :

1) Membuat standar untuk pelaksanaan yaitu:
   - Standar kualitas adalah suatu mutu dari bahan jadi dan pelayanan serta jasa yang harus ditentukan atau dibuat patokan (tolok ukur).
   - Standar kuantitas adalah ukuran berat, jumlah dan volume yang diwujudkan dalam ukuran bentuk.
   - Standar biaya adalah harga taksiran dari suatu barang atau jasa yang digunakan untuk mengukur biaya lain.
   - Standar prosedur adalah sebagai cara yang benar untuk kegiatan sehari-hari dalam proses penyelenggaraan makanan.
2) Melatih tenaga penyelenggaraan makanan untuk memahami dan melaksanakan standar-standar yang telah ditetapkan.
3) Memonitor, melihat, mengukur, mengecek pelaksanaan yang dilakukan kemudian membandingkan antara pelaksanaan kegiatan yang benar-benar dilakukan dengan standar yang telah dibuat sebelumnya.
4) Menetapkan tindakan perbaikan/koreksi untuk mengatasi penyimpangan dengan melaksanakan cara-cara yang telah disepakati berdasarkan data kegiatan terdahulu.

5. Pengendalian Biaya Tenaga / Harga Tenaga

a. Faktor yang mempengaruhi biaya:

e. Tipe menu dan besarnya persiapan yang diperlukan
f. Jenis pelayanan
g. Jumlah hidangan yang disajikan tiap hari
h. Jumlah dan jenis makanan yang dijual
i. Peralatan yang digunakan
j. Jumlah tenaga kerja

b. Penghematan penggunaan tenaga
1) Menu yang disajikan harus sederhana dan spesifik
2) Gunakan bahan makanan setengah jadi
3) Buat standar performance dan produktivitas
4) Perencanaan dan taksiran tenaga yang dibutuhkan
5) Perencanaan staff harus tepat
6) Jadwal harus ketat dan tepat
7) Gunakan tenaga paruh waktu atau secara kontrak
8) Awasi kelebihan waktu
9) Gunakan peralatan yang tepat dan cukup
10) Sederhanakan setiap prosedur
11) Latih tenaga kerja untuk meningkatkan performance
12) Tanamkan disiplin pada pegawai
13) Gunakan catatan dengan tepat
14) Awasi pertukaran pegawai
15) Lakukan reorganisasi bila perlu
16) Perbaiki lay-out fasilitas

B. Ciri Sistem Pengendalian Efektif

Sistem pengendalian efektif meliputi:

1. Terkoordinasi dengan arus kerja, dan dapat memberikan informasi langsung kepada atasan langsung.
2. Terfokus pada titik strategis, sistem harus jelas dan mudah dimengerti oleh orang-orang yang dikendalikan.
3. Objektif dan menyeluruh, sistem harus jelas dan mudah dimengerti oleh orang-orang yang dikendalikan.
4. Fleksibel. Sistem harus dibuat mudah, sehingga mudah diterapkan.
5. Secara ekonomi realistis, untung rugi pengendalian harus diperhitungkan secara realistis.

6. Secara organisasi harus realistis, jika sistem tidak realistis (standar yang ditetapkan terlalu tinggi), maka bawahan cenderung membuat laporan bias.
7. Akurat/tepat yaitu informasi yang dihasilkan oleh sistem harus benar.
8. Tepat waktu, informasi harus didapatkan dalam suatu waktu tertentu, sehingga dapat dilakukan koreksi bila diperlukan.
9. Sistem harus dapat diterima oleh semua pegawai.

C. Indikator Keberhasilan Pelayanan Gizi Rumah Sakit

1. Terselenggaranya diagnosis terhadap gangguan gizi dan metabolisme zat gizi berdasarkan anamnesis, antropometri, gejala klinis dan biokimia tubuh (laboratorium).
2. Terselenggaranya pengkajian dietetik dan pola makan berdasarkan anamnesis diet dan pola makan.
3. Terwujudnya penentuan kebutuhan gizi sesuai keadaan pasien.
4. Terwujudnya bentuk pembelian bahan makanan, pemilihan bahan makanan, jumlah pemberian serta cara pengolahan bahan makanan.
5. Terselenggaranya evaluasi terhadap preskripsi diet yang diberikan sesuai perubahan keadaan klinis, status gizi dan status laboratorium.
6. Terwujudnya penterjemahan preskripsi diet, penyediaan dan pengolahan sesuai dengan kebutuhan dan keadaan pasien.
7. Terlaksakannya penyelenggaraan penelitian aplikasi di bidang gizi dan diitetik.
8. Terwujudnya standar diet khusus sesuai perkembangan illmu pengetahuan dan teknologi yang dapat membantu penyembuhan penyakit.
9. Diselenggarakan penyuluhan dan konseling tentang pentingnya diet pada klien/pasien dan keluarganya.

D. Indikator Mutu Gizi di Rumah Sakit Daerah Kalabahi

1. Angka kesalahan pemberian diet

Ruang lingkup	:	pasien yang mendapatkan makanan dengan diet khusus
Tujuan	:	ketepatan pemberian diet sesuai dengan terapi diet.
Definisi operasional	:	semua pasien diet khusus mendapatkan makanan sesuai diet (kesalahan 0%).
Numerator	:	jumlah pasien diet yang mendapatkan makanan tidak

sesuai dengan diet (0%)

Denominator	:	semua pasien yang menjalankan diet khusus.
Standar	:	0%

2. Angka keterlambatan pengiriman makanan

Ruang lingkup	:	semua pasien yang makan.
Tujuan	:	mengetahui ketepatan pengiriman makanan.
Definisi operasiona	:	semua pasien mendapatkan makan sesuai jadwal.
Kriteria	:	pasien yang terlambat mendapatkan makanan lebih dari 1 jam jadwal makan yang telah di tetapkan.
Numerator	:	jumlah pasien yang terlambat mendapatkan makanan.
Denominator	:	semua pasien yang mendapatkan makan.
Standar	:	0%

BAB XI
PENUTUP

Pelayanan Gizi Rumah Sakit merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan paripurna di rumah sakit, yang terkait dengan keenam dasar fungsi rumah sakit, yaitu peningkatan, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, pendidikan dan penelitian.

Terapi gizi yang tepat dan penyuluhan gizi yang berhasil guna akan mempercepat penyembuhan, mencegah terjadinya gangguan gizi salah dan memperpendek hari rawat pasien. Keadaan ini akan memberikan dampak peningkatan pelayanan kesehatan di rumah sakit dalam rangka mencapai tujuan hidup Indonesia Sehat.

Buku Pedoman Pelayanan Gizi ini merupakan pedoman bagi pelaksanaan pelayanan gizi yang diselenggarakan di Rumah Sakit Daerah Kalabah. Dengan ini,, diharapkan pelayanan gizi yang diselenggarakan dapat terlaksana dengan baik dan dapat ditingkatkan seiring dengan kemajuan rumah sakit.

Ditetapkan di Kalabahi
Pada tanggal 01 Januari 2026
Direktur RSUD Kalabahi



dr.Lodywik Anjassius Ata Alopada
NIP: 198301082014121001

DAFTAR PUSTAKA

Kementrian Kesehatan RI. 2013. Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit. Jakarta

Lagua, Rosalinda T., & Claudio, Virginia S. 2004. Nutrition and Diet Therapy Reference Dictionary 5th.

Nurparida, Ida Siti., Marhaeni, Dewi., Arisanti, Nita. 2011. Peran Tim Terapi Gizi (TTG) dalam Mengatasi Malnutrisi Pasien Selama Dirawat Di Rumah Sakit: Suatu Kajian Literatur. Bandung : Universitas Padjadjaran.

Sunatrio dkk. 2009. Pedoman penyelenggaraan tim te rapi gizi di rumah sakit. Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Jakarta.

	PEMERINTAH KABUPATEN ALOR **RUMAH SAKIT DAERAH KALABAHI** Jln DR. Soetomo N0. 8 Telp (0386) 21008	No. RM Nama Pasien Tanggl Lahir Jenis Kelamin Ruangan	: : : : :
SKRINNING GIZI PASIEN			

Kuisioner Pengembangan SNST

Variabel	Pertanyaan	Skor
1. Kondisi pasien sekarang	Apakah pasien terlihat kurus?	
2. Penurunan berat badan	Apakah pakaian Anda terasa lebih longgar	
	Apakah akhir-akhir ini Anda kehilangan berat badan secara tidak sengaja (3 – 6 bulan terakhir)?	
	Apakah Anda mengalami penurunan asupan makan selama 1 minggu terakhir?	
	Apakah Anda merasa lemah, loyo, dan tidak bertenaga?	
	Apakah Anda menderita suatu penyakit yang mengakibatkan adanya perubahan jumlah atau jenis makanan yang Anda makan?	
Jumlah Skor		

Interpretasi Skors

Jumlah Skor	Interpretasi
0 – 2	Tidak berisiko
3 – 6	Berisiko

	PEMERINTAH KABUPATEN ALOR **RUMAH SAKIT DAERAH KALABAHI** Jln DR. Soetomo N0. 8 Telp (0386) 21008	No. RM NamaPasien Tanggl Lahir Jenis Kelamin Ruangan	: : : : :

ASESMEN GIZI ANAK

1. Risikomalnutrisiberdasasrkanhasilskrinninggiziolehperawat, kondisipasientermasukkategori?
   - ☐ RisikoRingan (nilai Strong Kids 0)
   - ☐ RisikoSedang (nilai Strong Kids 1-3)
   - ☐ Risikotinggi (nilai Strong Kids 4-5)
2. Pasienmempunyaikondisikhusus
   - ☐ Tidak ☐
3. Alergimakanan :
   - Telur ☐
   - Sususapidanprodukolahannya ☐
   - Ikan ☐
   - Dagingsapi ☐
   - Kacang-kacangan ☐
   - Dll.....
4. Perskripsi diet
   - Makanbiasa ☐
   - Diet khusus..... ☐
5. Tindaklanjut :
   - ☐ PerluAsuhanGizi (lanjutkankeAsesmenGiziLanjut)
   - ☐ BelumperluAsuhanGizi

ASESMEN GIZI LANJUT

Antropometri	BeratBadan (BB) : kg, PanjangBadan (PB) : cm BB Ideal 0-12 bln (0,5 x umur + 4) : kg BB Ideal 1-13 thn (2 x umur +8) : kg % BB Ideal (BBA/BBI x 100%) : %	
	Penilaian Status Gizi (Z-Score) :	
	BB/U : ☐ Buruk (< -3 SD) ☐ Kurang (≥ -3 SD s/d < -2 SD) ☐ Baik (≥ - SD s/d +2 SD) ☐ Lebih (> +2 SD s/d ≤ +3 SD) ☐ Obesitas (> +3 SD) **PB/U :** ☐ SangatPendek (< -3 SD) ☐ Pendek (≥ -3 SD s/d < -2 SD) ☐ Normal (≥ -2 SD s/d < +2 SD) ☐ Tinggi (> +2 SD) **BB/PB :** ☐ SangatKurus (< -3 SD) ☐ Kurus (≥ -3 SD s/d < -2 SD) ☐ Normal (≥ -2 SD s/d < +2 SD) ☐ Gemuk (> +2 SD)	**Klasifikasi :** Obesitas (> 120% BB Ideal) Overweight (> 110% - 120% BB Ideal) Gizi Normal (90% - 110% BB Ideal) GiziKurang (70% - 90 BB Ideal) GiziBuruk (< 70% BB Ideal)

Biokimia	1. Kreatinin :..... 2. Ureum :..... 3. BUN :.....	5. HBAC :..... 6. GDP :..... 7. GD 2JPP :.....	9. CHOL :..... 10. TG :..... 11. LDL :.....	13. SGPT :..... 14. SGOT :..... 15. ALBUMIN :.....

HARI/TANGGAL :						
Waktu makan :						
No.	**RUANGAN PERAWATAN**	**JUMLAH & JENIS DIET YANG DILAYANI**	**WAKTU**	**NAMA & PARAF PETUGAS**	**PERALATAN YANG DIGUNAKAN**	**KET .**
KET WAKTU PENDISTRIBUSIAN MAKANAN:						
PAGI : PKL. 06.00 - 07.00 WIB						
SIANG : PKL. 12.00 - 13.00 WIB						
MALAM : PKL. 18.00 - 19.00 WIB						